

Arsenal IGEDUC · Médico Perito Clínico Geral – Porto Calvo/AL

148 questões inéditas. Gabarito comentado ao final.

Português

O laudo que ninguém lê

Há documentos que nascem para ser arquivados. O laudo pericial, embora pareça pertencer a essa família, carrega uma ambição maior: traduzir um corpo em palavras capazes de orientar decisões que mudam vidas. Quando um perito conclui que alguém está incapaz para o trabalho, não descreve apenas uma condição clínica; autoriza, em certa medida, um novo arranjo de existência.

Por isso mesmo, causa estranheza que tantos laudos sejam escritos como se ninguém fosse lê-los. Frases truncadas, abreviaturas obscuras e conclusões sem fundamentação transformam o documento em enigma. O periciando não o compreende, o juiz hesita, o advogado o contesta. E o perito, que deveria ser a voz técnica do processo, torna-se apenas mais um ruído.

Escrever com clareza, contudo, não significa simplificar o que é complexo. Significa organizar o raciocínio de modo que o leitor percorra o mesmo caminho percorrido pelo autor: da história ao exame, do exame à análise, da análise à conclusão. Um laudo claro não é aquele que dispensa termos técnicos, mas aquele que os explica quando necessário e os articula em uma argumentação verificável.

Talvez o maior desafio esteja em reconhecer que a escrita também é parte do ato pericial. Não há exame bem feito que sobreviva a um texto mal construído.

1. (POR-001 · Interpretação e Análise Textual) Leia o texto 'O laudo que ninguém lê' para responder. Considerando a ideia central defendida pelo autor, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O texto sustenta que a clareza da escrita integra o ato pericial, pois o laudo orienta decisões sobre terceiros.
- (B) O texto sustenta que a responsabilidade pela compreensão do laudo cabe principalmente ao juiz e ao advogado.
- (C) O texto sustenta que o laudo pericial é documento essencialmente burocrático, destinado sobretudo ao arquivamento.
- (D) O texto sustenta que a clareza da escrita exige a eliminação de termos técnicos, pois o laudo se destina a leitores leigos.
- (E) O texto sustenta que a qualidade do exame clínico compensa eventuais falhas na redação do laudo pericial.

2. (POR-002 · Interpretação e Análise Textual) No trecho 'Escrever com clareza, contudo, não significa simplificar o que é complexo', do texto 'O laudo que ninguém lê', o conectivo destacado pode ser substituído, sem alteração de sentido, por:

- (A) assim, pois o conectivo estabelece relação de consequência com a ideia anterior.
- (B) porque, pois o conectivo estabelece relação de causa com a ideia anterior.
- (C) além disso, pois o conectivo estabelece relação de adição com a ideia anterior.
- (D) no entanto, pois o conectivo estabelece relação de oposição com o que foi dito.
- (E) portanto, pois o conectivo estabelece relação de conclusão com a ideia anterior.

3. (POR-003 · Interpretação e Análise Textual) No 2º parágrafo do texto 'O laudo que ninguém lê', afirma-se que o perito 'torna-se apenas mais um ruído'. Pode-se inferir dessa expressão que:

- (A) o laudo obscuro faz o perito ser responsabilizado criminalmente, por induzir o juiz a erro na sentença.
- (B) o laudo obscuro faz o perito ser ignorado pelo advogado, que deixa de contestar as conclusões apresentadas.
- (C) o laudo obscuro faz o perito perder a função de esclarecer, passando a gerar mais dúvidas no processo.
- (D) o laudo obscuro faz o perito ganhar relevância, pois suas conclusões passam a ser mais debatidas no processo.
- (E) o laudo obscuro faz o perito ser substituído por outro profissional, por determinação expressa do juiz.

4. (POR-004 · Sintaxe) No trecho 'Há documentos que nascem para ser arquivados', do texto 'O laudo que ninguém lê', o verbo 'haver' está corretamente empregado. Assinale a alternativa em que o verbo 'haver' também está empregado de acordo com a norma-padrão.

- (A) Devem haver muitas contestações ao laudo apresentado na audiência.
- (B) Houve muitas contestações ao laudo apresentado na audiência.
- (C) Haviam muitas contestações ao laudo apresentado na audiência.
- (D) Hão muitas contestações ao laudo apresentado na audiência.
- (E) Houveram muitas contestações ao laudo apresentado na audiência.

Território vivo

Durante muito tempo, o território foi tratado pela saúde pública como simples recorte geográfico: linhas traçadas no mapa para distribuir responsabilidades entre as equipes. Essa visão, embora útil para fins administrativos, revelou-se insuficiente para compreender por que pessoas que vivem a poucos quarteirões de distância adoecem e morrem de maneiras tão diferentes.

O conceito de território vivo propõe outra leitura. Nele, o espaço não é cenário neutro, mas produto das relações sociais, econômicas e culturais que ali se estabelecem. A ausência de saneamento, a violência, a distância até a escola e a oferta de trabalho compõem uma paisagem que a equipe de saúde precisa conhecer se quiser intervir de forma efetiva.

Conhecer o território, entretanto, não se resume a cadastrar famílias. Exige escuta, presença e disposição para reconhecer saberes que não cabem nos formulários. O agente comunitário que conhece a história de cada rua frequentemente percebe antes do sistema de informação aquilo que os indicadores só mostrarão meses depois.

Assim, mapear deixa de ser tarefa burocrática e passa a ser exercício de cuidado.

5. (POR-005 · Interpretação e Análise Textual) Leia o texto 'Território vivo' para responder. De acordo com o texto, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O território deve ser compreendido a partir do cadastro das famílias, que esgota o conhecimento necessário à equipe.
- (B) O território deve ser compreendido como cenário neutro, no qual as equipes aplicam protocolos padronizados.
- (C) O território deve ser compreendido pelos sistemas de informação, que antecipam o que os agentes comunitários percebem.
- (D) O território deve ser compreendido apenas como recorte geográfico, útil para distribuir responsabilidades entre equipes.

(E) O território deve ser compreendido como produto de relações sociais, econômicas e culturais, não só como recorte.

6. (POR-006 · Semântica) No trecho 'compõem uma paisagem que a equipe de saúde precisa conhecer', do texto 'Território vivo', a palavra 'paisagem' é empregada em sentido:

- (A) denotativo, referindo-se ao mapa físico elaborado pela equipe para delimitar as microáreas.
- (B) denotativo, referindo-se à vista natural observada pela equipe durante as visitas domiciliares.
- (C) conotativo, referindo-se à beleza dos bairros visitados pelos agentes comunitários de saúde.
- (D) conotativo, referindo-se ao conjunto de condições sociais que caracterizam o território.
- (E) técnico, referindo-se ao conceito de paisagem urbana adotado pelo planejamento municipal.

7. (POR-007 · Interpretação e Análise Textual) No trecho 'Nele, o espaço não é cenário neutro', do 2º parágrafo do texto 'Território vivo', o termo 'Nele' retoma:

- (A) o quarteirão onde vivem as pessoas, mencionado ao final do primeiro parágrafo.
- (B) o recorte geográfico, apresentado no primeiro parágrafo como visão tradicional.
- (C) o conceito de território vivo, apresentado no período imediatamente anterior.
- (D) o sistema de informação, apresentado como fonte dos indicadores de saúde.
- (E) o mapa das equipes, mencionado como instrumento de distribuição de responsabilidades.

8. (POR-008 · Sintaxe) Considere o trecho do texto 'Território vivo': 'Conhecer o território, entretanto, não se resume a cadastrar famílias.' Assinale a afirmativa CORRETA sobre a pontuação.

- (A) As vírgulas isolam a conjunção deslocada 'entretanto', sendo, por isso, obrigatórias.
- (B) As vírgulas isolam um vocativo dirigido ao leitor do texto.
- (C) As vírgulas isolam um aposto explicativo que define o termo 'território'.
- (D) As vírgulas são facultativas, podendo ser retiradas sem prejuízo à norma-padrão.
- (E) As vírgulas separam o sujeito do verbo, uso permitido sempre que o sujeito for oracional.

9. (POR-009 · Sintaxe) Assinale a alternativa em que o uso do acento indicativo de crase está de acordo com a norma-padrão.

- (A) O perito referiu-se à conclusão do laudo durante a audiência.
- (B) O perito dirigiu-se à Vossa Excelência durante a audiência.
- (C) O perito chegou à pé ao local da audiência.
- (D) O perito começou à examinar o periciando na audiência.
- (E) O perito referiu-se à um laudo anterior durante a audiência.

10. (POR-010 · Sintaxe) Assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma-padrão.

- (A) A perita visava o cargo de coordenação desde o concurso.
- (B) A perita assistiu ao vídeo da audiência antes de concluir o laudo.
- (C) A perita obedeceu o protocolo estabelecido pelo instituto.
- (D) A perita assistiu o vídeo da audiência antes de concluir o laudo.
- (E) A perita preferia mais revisar o laudo do que entregá-lo às pressas.

11. (POR-011 · Fonologia) Considerando as regras de acentuação gráfica vigentes após o Acordo Ortográfico, assinale a alternativa em que todas as palavras estão corretamente grafadas.

- (A) idéia, heróico, vôo, crêem
- (B) ideia, heroico, voo, creem
- (C) idéia, heroico, vôo, creem
- (D) ideia, heróico, voo, creem
- (E) ideia, heroico, vôo, crêem

12. (POR-012 · Redação Oficial) A perita municipal precisa encaminhar ofício ao Juiz de Direito da comarca. Considerando o Manual de Redação da Presidência da República (3ª ed.), assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Deve usar o tratamento Vossa Senhoria, com concordância na segunda pessoa, e o fecho 'Atenciosamente'.
- (B) Deve usar o vocativo 'Digníssimo Senhor Juiz' e o fecho 'Atenciosamente', por ser autoridade de mesma hierarquia.
- (C) Deve usar o tratamento Vossa Excelência, com concordância na terceira pessoa, e o fecho 'Respeitosamente'.
- (D) Deve usar o tratamento Vossa Excelência, com concordância na segunda pessoa do plural, e o fecho 'Cordialmente'.
- (E) Deve usar o tratamento Vossa Magnificência, com concordância na terceira pessoa, e o fecho 'Respeitosamente'.

13. (POR-013 · Morfologia) Assinale a alternativa em que a palavra foi formada por derivação parassintética.

- (A) infelizmente
- (B) combate
- (C) girassol
- (D) planalto
- (E) entardecer

Constitucional

14. (CON-001 · Administração Pública na CF) Médica aprovada para perita municipal (30 h semanais) já ocupa cargo efetivo de médica no Estado (20 h semanais). Considerando o art. 37, XVI, da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A acumulação é permitida apenas se um dos cargos for de professor, por exigência expressa do texto constitucional.
- (B) A acumulação é vedada, pois a Constituição proíbe acumular cargo efetivo estadual com cargo efetivo municipal.
- (C) A acumulação é permitida por se tratar de dois cargos privativos de profissionais de saúde, com horários compatíveis.
- (D) A acumulação é permitida independentemente da compatibilidade de horários, por se tratar de profissionais de saúde.
- (E) A acumulação é vedada, pois a Constituição só admite acumular cargos públicos quando ambos pertencem ao mesmo ente federativo.

15. (CON-002 · Administração Pública na CF) Considerando as regras constitucionais sobre concurso público, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O prazo de validade do concurso público será de exatamente dois anos, vedada qualquer prorrogação.
- (B) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- (C) O prazo de validade do concurso público será de até quatro anos, prorrogável uma vez, por igual período.
- (D) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável sucessivas vezes, a critério da Administração.
- (E) O prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por período de até seis meses.

16. (CON-003 · Administração Pública na CF) Servidora nomeada em cargo efetivo, após aprovação em concurso, completou três anos de exercício. Considerando o art. 41 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A aquisição da estabilidade exige três anos de efetivo exercício e avaliação especial de desempenho por comissão.
- (B) A aquisição da estabilidade exige dois anos de efetivo exercício, dispensada a avaliação especial de desempenho.
- (C) A aquisição da estabilidade exige três anos de exercício, sendo estendida também aos ocupantes de cargos em comissão.
- (D) A aquisição da estabilidade ocorre automaticamente com a posse, sendo o estágio probatório mera formalidade administrativa.
- (E) A aquisição da estabilidade exige três anos de exercício, após os quais o servidor só perde o cargo por sentença judicial.

17. (CON-004 · Responsabilidade do Estado) Paciente sofreu queimadura por falha de equipamento durante procedimento em hospital municipal. Considerando o art. 37, § 6º, da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O município responde objetivamente pelo dano apenas se o paciente tiver pago pelo atendimento recebido.
- (B) O município não responde pelo dano, que deve ser cobrado diretamente do servidor que operava o equipamento.
- (C) O município responde objetivamente pelo dano, assegurado o regresso contra o servidor independentemente de dolo ou culpa.
- (D) O município responde objetivamente pelo dano, com direito de regresso contra o agente em caso de dolo ou culpa.
- (E) O município responde subjetivamente pelo dano, cabendo à vítima provar a culpa do servidor que operava o equipamento.

18. (CON-005 · Remédios constitucionais) Servidor teve negado pelo município o acesso às informações sobre sua pessoa constantes do registro funcional e deseja conhecê-las e retificá-las. Considerando os remédios constitucionais, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O instrumento adequado é a ação popular, que assegura ao servidor o acesso a informações pessoais em registros de entidades governamentais.
- (B) O instrumento adequado é o habeas data, cuja impetração exige advogado e o pagamento prévio de custas judiciais.
- (C) O instrumento adequado é o habeas corpus, que assegura o conhecimento e a retificação de informações relativas à pessoa do impetrante.

(D) O instrumento adequado é o mandado de injunção, que assegura o conhecimento e a retificação de informações pessoais em registros públicos.

(E) O instrumento adequado é o habeas data, que assegura o conhecimento e a retificação de informações pessoais em registros públicos.

19. (CON-006 · Remédios constitucionais) Considerando a legitimidade para impetrar mandado de segurança coletivo, prevista no art. 5º, LXX, da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Pode ser impetrado por qualquer partido político, ainda que sem representação no Congresso Nacional.

(B) Pode ser impetrado pelo Ministério Público, que detém legitimidade exclusiva para a defesa de interesses coletivos.

(C) Pode ser impetrado por associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos dois anos, em defesa de seus membros.

(D) Pode ser impetrado por qualquer cidadão em pleno gozo dos direitos políticos, em defesa do patrimônio público.

(E) Pode ser impetrado por associação constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos associados.

20. (CON-007 · Direitos políticos) Considerando as regras sobre alistamento eleitoral e voto do art. 14 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de sessenta e os maiores de dezesseis e menores de dezoito.

(B) O alistamento e o voto são facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

(C) O alistamento e o voto são facultativos para os maiores de dezoito anos que residam no exterior.

(D) O alistamento e o voto são vedados aos maiores de dezesseis e menores de dezoito anos.

(E) O alistamento e o voto são obrigatórios para os analfabetos, por exigência do princípio da igualdade política.

21. (CON-008 · Direitos políticos) Considerando as idades mínimas exigidas como condição de elegibilidade pela Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Exige-se idade mínima de vinte e um anos para Prefeito e Vice-Prefeito, e de dezoito anos para Vereador.

(B) Exige-se idade mínima de vinte e cinco anos para Prefeito e Vice, e de vinte e um para Vereador.

(C) Exige-se idade mínima de dezoito anos para Prefeito e Vice-Prefeito, e de dezesseis anos para Vereador.

(D) Exige-se idade mínima de trinta anos para Prefeito e Vice-Prefeito, e de vinte e um anos para Vereador.

(E) Exige-se idade mínima de vinte e um anos para Prefeito, e de trinta e cinco anos para Vereador.

22. (CON-009 · Princípios fundamentais) O art. 1º da Constituição Federal enumera os fundamentos da República Federativa do Brasil. Assinale a afirmativa INCORRETA.

(A) É fundamento da República a dignidade da pessoa humana.

(B) É fundamento da República a soberania.

(C) É fundamento da República o pluralismo político.

(D) É fundamento da República a cidadania.

(E) É fundamento da República erradicar a pobreza.

23. (CON-010 · Federalismo e organização do Estado) Vereador apresentou projeto de lei municipal sobre normas gerais de previdência social para os servidores de saúde, alegando competência concorrente. Considerando a repartição de competências da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Compete ao Município prestar serviços de saúde à população, com cooperação técnica e financeira da União e do Estado.
- (B) Compete ao Município prestar serviços de saúde, vedada a cooperação técnica e financeira dos demais entes.
- (C) Compete ao Município cuidar da saúde com exclusividade, vedada a atuação comum da União e dos Estados.
- (D) Compete ao Município legislar privativamente sobre seguridade social, por se tratar de assunto de interesse local.
- (E) Compete ao Município legislar concorrentemente com a União sobre previdência social e proteção e defesa da saúde.

24. (CON-011 · Processo legislativo) Considerando o processo de emenda à Constituição previsto no art. 60 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A proposta é discutida e votada em sessão unicameral do Congresso, em turno único, aprovada por maioria absoluta.
- (B) A proposta é discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, e depois submetida à sanção do Presidente da República.
- (C) A proposta é discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, e aprovada se obtiver três quintos dos votos dos membros.
- (D) A proposta é discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, podendo tramitar durante intervenção federal.
- (E) A proposta é discutida e votada em cada Casa, em dois turnos, aprovada se obtiver dois terços dos votos dos membros.

25. (CON-012 · Poder constituinte) Considerando as limitações materiais ao poder de reforma da Constituição (cláusulas pétreas), assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma republicana de governo e o voto obrigatório.
- (B) Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir o voto direto, secreto, universal e obrigatório.
- (C) Não será objeto de deliberação proposta de emenda que modifique a organização do sistema tributário nacional.
- (D) Não será objeto de deliberação proposta de emenda tendente a abolir a forma federativa e a separação dos Poderes.
- (E) Não será objeto de deliberação proposta de emenda que altere qualquer dispositivo relativo aos direitos sociais.

26. (CON-013 · Controle de constitucionalidade) Considerando os legitimados para propor ação direta de inconstitucionalidade perante o STF, conforme o art. 103 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Podem propor a ação, entre outros, o sindicato de âmbito municipal e a federação sindical estadual.
- (B) Podem propor a ação, entre outros, o Conselho Federal da OAB e confederação sindical de âmbito nacional.
- (C) Podem propor a ação, entre outros, qualquer cidadão no pleno exercício de seus direitos políticos.

(D) Podem propor a ação, entre outros, qualquer partido político registrado, ainda que sem representação no Congresso.

(E) Podem propor a ação, entre outros, o Prefeito Municipal e a Mesa da Câmara de Vereadores.

27. (CON-014 · Aplicabilidade e interpretação das normas) Segundo a classificação de José Afonso da Silva quanto à aplicabilidade das normas constitucionais, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Normas de eficácia contida têm aplicabilidade imediata, mas podem ter seu alcance restringido por lei.

(B) Normas de eficácia limitada têm aplicabilidade imediata e integral, sendo vedada sua regulamentação por lei.

(C) Normas de eficácia contida dependem de lei para produzir qualquer efeito, não tendo aplicabilidade imediata.

(D) Normas de eficácia plena dependem de regulamentação para produzir efeitos, podendo ser restringidas por lei.

(E) Normas de eficácia contida não admitem restrição por lei, pois sua aplicabilidade é integral e imutável.

28. (CON-015 · Segurança pública na Constituição) Considerando o art. 144 da Constituição Federal, que trata da segurança pública, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Os Municípios poderão constituir polícias militares municipais, subordinadas diretamente ao prefeito.

(B) Os Municípios poderão constituir guardas municipais para proteção de seus bens, serviços e instalações.

(C) Os Municípios poderão constituir guardas municipais, com competência exclusiva para o policiamento ostensivo.

(D) Os Municípios poderão constituir guardas municipais, vinculadas ao comando da Polícia Federal.

(E) Os Municípios deverão obrigatoriamente constituir guardas municipais, com atribuição de polícia judiciária local.

29. (CON-016 · Sistema tributário nacional) O município pretende cobrar pela coleta domiciliar de lixo e pelo licenciamento sanitário de estabelecimentos. Considerando o art. 145 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Os municípios podem instituir impostos vinculados ao custeio específico da coleta de lixo e do licenciamento sanitário.

(B) Os municípios não podem instituir taxas, pois essa espécie tributária é de competência exclusiva da União.

(C) Os municípios podem instituir contribuição de melhoria para custear a coleta de lixo e o licenciamento sanitário.

(D) Os municípios podem instituir taxas pelo poder de polícia ou por serviços públicos específicos e divisíveis.

(E) Os municípios podem instituir taxas com base de cálculo idêntica à de impostos, como o valor venal do imóvel.

30. (CON-017 · Organização dos Poderes) Considerando o regime das medidas provisórias previsto no art. 62 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) É permitida a edição de medida provisória sobre nacionalidade, cidadania e direitos políticos, em caso de urgência.

(B) É permitida a edição de medida provisória sobre matéria reservada a lei complementar, em caso de urgência.

- (C) É vedada a edição de medida provisória sobre direito penal, processual penal e processual civil.
- (D) É vedada a edição de medida provisória por prazo superior a trinta dias, improrrogáveis.
- (E) É vedada a edição de medida provisória sobre qualquer matéria tributária, inclusive impostos.

Informática

31. (INF-001 · Utilização de planilhas eletrônicas) No Excel, a célula B1 contém o valor da diária (R\$ 150). Em A2:A10 há a quantidade de dias de cada servidor, e a fórmula de B2 será copiada até B10 para calcular o total de cada um. Assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A fórmula adequada em B2 é =A2*B1, pois o Excel ajusta B1 automaticamente para o valor correto em cada linha.
- (B) A fórmula adequada em B2 é =A2*\$B\$1, pois a referência absoluta mantém fixa a célula da diária ao copiar.
- (C) A fórmula adequada em B2 é =A2*#B#1, pois o símbolo # fixa linha e coluna da célula referenciada.
- (D) A fórmula adequada em B2 é =SOMA(A2:B1), pois a função soma multiplica a quantidade pelo valor da diária.
- (E) A fórmula adequada em B2 é =\$A\$2*B1, pois a referência absoluta deve recair sobre a quantidade de dias.

32. (INF-002 · Utilização de planilhas eletrônicas) Em uma planilha do Excel em português, a coluna C traz a nota da prova objetiva de cada candidato. Deseja-se exibir em D2 'Aprovado' se a nota em C2 for maior ou igual a 70 e 'Eliminado' caso contrário. Assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A fórmula adequada é =SE(C2>=70;"Aprovado";"Eliminado"), com ponto e vírgula separando os argumentos.
- (B) A fórmula adequada é =SE("Aprovado";C2>=70;"Eliminado"), pois o primeiro argumento é o valor verdadeiro.
- (C) A fórmula adequada é =SE(C2>=70;Aprovado;Eliminado), pois textos dispensam aspas em funções lógicas.
- (D) A fórmula adequada é =SE(C2>70;"Aprovado";"Eliminado"), pois o operador > inclui a nota 70.
- (E) A fórmula adequada é =CONT.SE(C2>=70;"Aprovado";"Eliminado"), pois a função conta os aprovados.

33. (INF-003 · Utilização de planilhas eletrônicas) Em planilha do Excel, o intervalo A1:A20 contém os valores 'Apto' ou 'Inapto' de laudos periciais. Assinale a afirmativa CORRETA sobre a função que conta quantos laudos são 'Apto'.

- (A) A fórmula =SOMA(A1:A20;"Apto") retorna o número de células do intervalo cujo conteúdo é 'Apto'.
- (B) A fórmula =CONT.VALORES("Apto";A1:A20) retorna o número de células do intervalo cujo conteúdo é 'Apto'.
- (C) A fórmula =CONT.NÚM(A1:A20;"Apto") retorna o número de células do intervalo cujo conteúdo é 'Apto'.
- (D) A fórmula =MÉDIA(A1:A20;"Apto") retorna o número de células do intervalo cujo conteúdo é 'Apto'.
- (E) A fórmula =CONT.SE(A1:A20;"Apto") retorna o número de células do intervalo cujo conteúdo é 'Apto'.

34. (INF-004 · Aplicativos de escritório) No Microsoft Word em português do Brasil, com configuração padrão, assinale a afirmativa CORRETA sobre teclas de atalho.

- (A) O atalho Ctrl+N aplica negrito ao texto selecionado, e Ctrl+B salva o documento.
- (B) O atalho Ctrl+S aplica negrito ao texto selecionado, e Ctrl+B salva o documento.
- (C) O atalho Ctrl+N cria um novo documento em branco, e Ctrl+B salva o documento.

(D) O atalho Ctrl+B aplica negrito ao texto selecionado, e Ctrl+N salva o documento.

(E) O atalho Ctrl+I aplica negrito ao texto selecionado, e Ctrl+S salva o documento.

35. (INF-005 · Conceitos de sistemas operacionais) No Windows 10/11, com configuração padrão, assinale a afirmativa CORRETA sobre teclas de atalho.

(A) A combinação Windows+L abre o Explorador de Arquivos, exibindo as unidades e pastas do computador.

(B) A combinação Windows+L bloqueia a sessão, exigindo nova autenticação para retomar o uso.

(C) A combinação Windows+L minimiza todas as janelas e exibe a área de trabalho do usuário.

(D) A combinação Windows+L abre o Gerenciador de Tarefas, permitindo encerrar programas travados.

(E) A combinação Windows+L abre as Configurações do sistema, permitindo alterar preferências.

36. (INF-006 · Conceitos sobre armazenamento e gerenciamento de arquivos) Servidora selecionou no Explorador de Arquivos do Windows um arquivo com dados de periciandos, em disco local, e pressionou Shift+Delete, confirmando a ação. Assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O arquivo é enviado à Lixeira, podendo ser restaurado à pasta original a qualquer momento.

(B) O arquivo é ocultado, permanecendo no disco, mas invisível no Explorador até nova configuração.

(C) O arquivo é excluído sem passar pela Lixeira, não podendo ser restaurado por ela.

(D) O arquivo é renomeado, recebendo a extensão .bak para indicar que se trata de cópia de segurança.

(E) O arquivo é copiado para a área de transferência, sendo excluído apenas após ser colado em outro local.

37. (INF-007 · Conceitos de segurança da informação e proteção de dados) Considerando os tipos de códigos maliciosos, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O ransomware disfarça-se de programa legítimo para instalar funções maliciosas sem o conhecimento do usuário.

(B) O ransomware torna os dados inacessíveis, geralmente por criptografia, e exige resgate para liberá-los.

(C) O ransomware registra as teclas digitadas pelo usuário para capturar senhas e enviá-las a terceiros.

(D) O ransomware mantém acesso remoto oculto ao equipamento, permitindo o retorno do invasor posteriormente.

(E) O ransomware propaga-se automaticamente pela rede sem precisar de arquivo hospedeiro, explorando vulnerabilidades.

38. (INF-008 · Conceitos de segurança da informação e proteção de dados) Servidor recebeu e-mail com logotipo do banco solicitando que clicasse em link para 'atualizar dados cadastrais' em até 24 horas, sob pena de bloqueio da conta. Assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Trata-se de ataque de negação de serviço, que torna indisponível o servidor de e-mail institucional.

(B) Trata-se de tentativa de phishing, golpe que só ocorre por e-mail, sendo impossível por SMS ou aplicativo.

(C) Trata-se de backup automático, procedimento do banco para resguardar os dados do correntista.

(D) Trata-se de spam legítimo, comunicação comercial autorizada que não oferece risco ao usuário.

(E) Trata-se de tentativa de phishing, golpe que usa mensagens falsas para obter dados pessoais.

39. (INF-009 · Ferramentas de backup e recuperação de dados) Considerando os tipos de backup, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O backup diferencial copia apenas os arquivos alterados desde o último backup de qualquer tipo, sendo o mais rápido de restaurar.
- (B) O backup incremental copia todos os arquivos alterados desde o último backup completo, exigindo, na restauração, apenas o último incremental.
- (C) O backup incremental copia só o que mudou desde o último backup de qualquer tipo, exigindo o completo e todos os incrementais.
- (D) O backup incremental copia todos os arquivos do sistema a cada execução, independentemente de alteração.
- (E) O backup completo copia apenas os arquivos alterados, sendo dispensável para restaurar os backups incrementais.

40. (INF-010 · Conceitos sobre protocolos de comunicação na internet) Considerando os protocolos utilizados no serviço de correio eletrônico, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O SMTP é usado no envio de mensagens, enquanto o IMAP permite acessar e sincronizar as mensagens mantidas no servidor.
- (B) O SMTP é usado no recebimento de mensagens, enquanto o POP3 sincroniza pastas entre vários dispositivos.
- (C) O HTTP é usado no envio de mensagens, enquanto o FTP permite acessar e sincronizar as mensagens mantidas no servidor.
- (D) O POP3 é usado no envio de mensagens, enquanto o DNS permite acessar e sincronizar as mensagens mantidas no servidor.
- (E) O IMAP é usado no envio de mensagens, enquanto o SMTP permite acessar e sincronizar as mensagens no servidor.

41. (INF-011 · E-mail e comunicação eletrônica no ambiente corporativo) A coordenação da perícia vai enviar convocação por e-mail a 40 periciandos e não deseja que um destinatário veja o endereço dos demais. Assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Os endereços devem ser incluídos no campo CCO, que, porém, os revela a quem responde a todos.
- (B) Os endereços devem ser incluídos no campo CC (com cópia), que impede a visualização dos demais destinatários.
- (C) Os endereços devem ser incluídos no campo Para, que oculta automaticamente os destinatários após o envio.
- (D) Os endereços devem ser incluídos no campo CCO (cópia oculta), que impede a visualização dos demais destinatários.
- (E) Os endereços devem ser incluídos no campo Assunto, separados por ponto e vírgula, para manter o sigilo.

42. (INF-012 · Noções de computação em nuvem) Considerando os modelos de serviço de computação em nuvem, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) No modelo IaaS, o usuário utiliza o software pronto pela internet, sem gerenciar a infraestrutura em que ele roda.
- (B) No modelo SaaS, o usuário contrata servidores virtuais e gerencia o sistema operacional e as aplicações instaladas.
- (C) No modelo PaaS, o usuário recebe apenas o hardware físico, devendo instalá-lo em suas próprias dependências.
- (D) No modelo SaaS, o usuário utiliza o software pronto pela internet, sem gerenciar a infraestrutura subjacente.

(E) No modelo SaaS, o usuário é responsável pela manutenção física dos servidores do provedor de nuvem.

43. (INF-013 · Conceitos de segurança da informação e proteção de dados) O setor de perícia mantém planilhas com nome, CPF e diagnósticos (CID) dos servidores avaliados. Considerando a Lei Geral de Proteção de Dados (Lei nº 13.709/2018), assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Dados referentes à saúde são dados pessoais sensíveis, cujo tratamento depende sempre do consentimento do titular.

(B) Dados referentes à saúde são dados pessoais comuns, equiparados ao nome e ao endereço para fins de proteção legal.

(C) Dados referentes à saúde são dados pessoais sensíveis, cujo tratamento exige hipóteses legais específicas.

(D) Dados referentes à saúde podem ser compartilhados livremente entre setores, desde que anonimizados apenas pelo CPF.

(E) Dados referentes à saúde ficam fora do alcance da LGPD quando tratados pelo poder público em suas atividades.

Perícia

44. (PER-001 · Perícia médica previdenciária) Segurado com primeira filiação ao RGPS em março de 2025 requer auxílio por incapacidade temporária em agosto de 2025. Documentos mostram lombalgia desde 2023 (DID); em julho de 2025 surgiu hérnia discal extrusa com déficit motor, fixada como DII. Não há acidente nem doença isenta de carência. Considerando a Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O ponto decisivo é o agravamento: comprovada a progressão da doença, fica dispensada a carência de doze contribuições mensais.

(B) O ponto decisivo é a DER: a incapacidade deve ser fixada na data do requerimento, momento em que a carência já teria sido cumprida.

(C) O ponto decisivo é a preexistência: a doença anterior à filiação impede sempre o benefício, mesmo que a incapacidade decorra de agravamento.

(D) O ponto decisivo é a carência: sem doze contribuições e fora das hipóteses de isenção, o agravamento não basta para o benefício.

(E) O ponto decisivo é a DID: fixada a doença em 2023, o perito deve indeferir por preexistência, sendo irrelevante a data da incapacidade.

45. (PER-002 · Perícia médica previdenciária) Segurada filiada ao RGPS há quatro meses recebe diagnóstico de carcinoma de mama, iniciado após a filiação, e fica incapacitada durante a quimioterapia. Considerando a Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A neoplasia maligna acometida após a filiação dispensa a carência, sendo devido o benefício se presente a incapacidade.

(B) A neoplasia maligna dispensa a carência apenas quando a incapacidade for permanente, exigindo-se doze contribuições para benefício temporário.

(C) A neoplasia maligna dispensa a carência mesmo quando já existente antes da filiação ao RGPS, sem qualquer ressalva legal.

(D) A neoplasia maligna dispensa a carência, sendo devido o benefício independentemente da constatação de incapacidade laboral.

(E) A neoplasia maligna não integra o rol de doenças que dispensam carência, exigindo-se doze contribuições na data da incapacidade.

46. (PER-003 · Perícia médica previdenciária) Motorista de aplicativo, contribuinte individual, sofreu acidente doméstico com amputação da falange distal do indicador dominante. Após consolidação, há redução da capacidade para a atividade habitual, sem incapacidade total. Considerando a Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O segurado faz jus ao auxílio-acidente, desde que tenha cumprido carência de doze contribuições mensais antes do acidente.
- (B) O segurado não faz jus ao auxílio-acidente, pois o benefício não alcança o contribuinte individual, embora dispense carência.
- (C) O segurado não faz jus ao auxílio-acidente, pois o benefício só é devido quando o acidente tem natureza ocupacional.
- (D) O segurado faz jus ao auxílio-acidente, pois o benefício alcança todos os segurados do RGPS que sofram acidente de qualquer natureza.
- (E) O segurado não faz jus ao auxílio-acidente, pois a amputação de falange não configura sequela consolidada indenizável.

47. (PER-004 · Perícia médica previdenciária) Considerando o auxílio-acidente disciplinado no art. 86 da Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O benefício tem natureza indenizatória, é concedido após a consolidação das lesões e permite ao segurado continuar trabalhando.
- (B) O benefício tem natureza assistencial, é concedido independentemente de filiação e cessa quando o segurado volta a trabalhar.
- (C) O benefício tem natureza indenizatória, mas só é concedido quando a sequela gera incapacidade total para o trabalho.
- (D) O benefício tem natureza indenizatória, é concedido após a consolidação e corresponde a 100% do salário de benefício.
- (E) O benefício tem natureza substitutiva da renda, é concedido durante o tratamento e impede o retorno do segurado ao trabalho.

48. (PER-005 · Avaliação de invalidez e incapacidade permanente) Aposentado por incapacidade permanente após AVC evoluiu com hemiplegia e afasia, necessitando de ajuda de terceiros para alimentação e higiene. O valor de sua aposentadoria já está no teto do RGPS. Considerando a Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Necessitando de assistência permanente de outra pessoa, faz jus ao acréscimo de 25%, que se incorpora à pensão por morte.
- (B) Necessitando de assistência permanente de outra pessoa, faz jus ao acréscimo de 25%, devido ainda que o valor ultrapasse o teto.
- (C) Necessitando de assistência permanente de outra pessoa, faz jus ao acréscimo de 25%, limitado, porém, ao teto do RGPS.
- (D) Necessitando de assistência de terceiros, não faz jus a acréscimo, pois a dependência funcional já integra a incapacidade permanente.
- (E) Necessitando de assistência de terceiros, faz jus ao acréscimo de 50%, devido a qualquer aposentado do RGPS em igual situação.

49. (PER-006 · Perícia médica previdenciária) Em revisão de auxílio por incapacidade temporária, segurado com hérnia discal recusa a cirurgia indicada pelo assistente, mas mantém fisioterapia. O perito cogita cessar o benefício pela recusa. Considerando a Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A recusa à cirurgia não autoriza a cessação, mas obriga a conversão automática em aposentadoria por incapacidade permanente.

(B) A recusa à cirurgia não autoriza a cessação, e o segurado fica também dispensado de comparecer aos exames periciais periódicos.

(C) A recusa à cirurgia autoriza a cessação, pois o segurado é obrigado a submeter-se a todo tratamento prescrito pelo médico assistente.

(D) A recusa à cirurgia não autoriza a cessação, pois o tratamento cirúrgico e a transfusão de sangue são facultativos ao segurado.

(E) A recusa à cirurgia autoriza a cessação imediata, salvo se o segurado apresentar segunda opinião médica contrária à indicação.

50. (PER-007 · Incapacidade temporária / permanente) Considerando as regras da Lei nº 8.213/1991 sobre a duração do auxílio por incapacidade temporária, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Sempre que possível, o ato de concessão fixa prazo estimado, que não pode ser prorrogado ainda que persista a incapacidade.

(B) Sempre que possível, o ato de concessão fixa prazo estimado; na ausência, o benefício cessa após 60 dias, vedada a prorrogação.

(C) Em nenhuma hipótese o ato de concessão fixa prazo, cabendo ao segurado solicitar a cessação quando recuperar a capacidade.

(D) Sempre que possível, o ato de concessão fixa prazo estimado; na ausência, o benefício é mantido até nova perícia.

(E) Sempre que possível, o ato de concessão fixa prazo estimado; na ausência, o benefício cessa após 120 dias, salvo pedido de prorrogação.

51. (PER-008 · Avaliação da capacidade laborativa) Pedreiro de 38 anos com ruptura completa do manguito rotador do ombro dominante, em pós-operatório, está incapaz para elevar o membro acima da cabeça e carregar peso; o ortopedista prevê recuperação em seis meses. Considerando a avaliação da capacidade laborativa, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Há incapacidade parcial e permanente, devendo ser concedido desde logo o auxílio-acidente pela redução da capacidade.

(B) Há incapacidade total e temporária, devendo o segurado ser encaminhado de imediato à reabilitação para nova profissão.

(C) Há incapacidade total e temporária para a atividade habitual, com prognóstico de recuperação em alguns meses.

(D) Há capacidade preservada, pois o segurado pode exercer outra atividade compatível, ainda que não a habitual.

(E) Há incapacidade total e permanente para qualquer atividade, pois a lesão no membro dominante inviabiliza o trabalho manual.

52. (PER-009 · Perícia médica previdenciária) Motorista de caminhão com epilepsia refratária e crises mensais, apesar de tratamento otimizado, tem 38 anos, ensino médio e boa capacidade cognitiva. Considerando a Lei nº 8.213/1991 e a avaliação pericial, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Há incapacidade apenas para dirigir veículos leves, mantendo-se a aptidão para veículos de carga com acompanhante.

(B) Há incapacidade total e permanente para qualquer atividade, devendo ser concedida desde logo a aposentadoria.

(C) Há incapacidade temporária para a atividade habitual, devendo o benefício ser mantido até o controle total das crises.

(D) Há capacidade plena para a atividade habitual, pois a epilepsia controlada parcialmente não impede a direção profissional.

(E) Há incapacidade para a atividade habitual sem perspectiva de retorno, sendo indicada reabilitação profissional para atividade sem risco.

53. (PER-010 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Trabalhador rural de 61 anos, com gonartrose bilateral, requer reconhecimento de doença do trabalho. Não há registro de exposição específica que tenha contribuído diretamente para o agravo. Considerando a Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A doença degenerativa ou inerente a grupo etário não é doença do trabalho, salvo prova de contribuição direta do trabalho.

(B) A doença degenerativa é considerada doença do trabalho quando gera incapacidade, independentemente de nexos com a atividade.

(C) A doença degenerativa nunca pode ter relação com o trabalho, sendo vedada a análise de concausa pelo perito.

(D) A doença degenerativa é sempre considerada doença do trabalho quando o segurado exerce atividade que exige esforço físico.

(E) A doença degenerativa é considerada doença profissional, por ser peculiar à atividade rural segundo o regulamento.

54. (PER-011 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Agente de combate às endemias que realizava busca ativa em área de mata contraiu leishmaniose tegumentar, doença endêmica na região. Considerando o art. 20 da Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A doença endêmica nunca é considerada doença do trabalho, por ser adquirida por qualquer habitante da região.

(B) A doença endêmica é sempre considerada doença do trabalho para servidores públicos que atuam na região.

(C) A doença endêmica pode ser doença do trabalho quando decorre de exposição determinada pela natureza do trabalho.

(D) A doença endêmica só é considerada doença do trabalho se constar da lista de doenças profissionais da CLT.

(E) A doença endêmica é considerada doença do trabalho desde que o trabalhador resida fora da área endêmica.

55. (PER-012 · Nexos técnico epidemiológico) Bancária afastada por transtorno depressivo teve o benefício caracterizado como acidentário pelo NTEP, embora a empresa não tenha emitido CAT. A empresa discorda. Considerando o art. 21-A da Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O NTEP gera presunção relativa, a partir do cruzamento CNAE × CID, que a empresa pode contestar com efeito suspensivo.

(B) O NTEP gera presunção absoluta a partir da relação entre a atividade da empresa e o CID, sendo vedada qualquer contestação pela empresa.

(C) O NTEP depende da emissão prévia da CAT pela empresa, sem a qual a perícia não pode caracterizar a natureza acidentária.

(D) O NTEP gera presunção relativa, mas o requerimento de não aplicação pela empresa não tem efeito suspensivo.

(E) O NTEP decorre da avaliação individual do posto de trabalho pelo perito, dispensando dados estatísticos de adoecimento.

56. (PER-013 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Operário sofreu queda de andaime numa sexta-feira à tarde, sem óbito. A empresa não emitiu a CAT, e o médico que o atendeu no pronto-socorro pretende emití-la. Considerando o art. 22 da Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A empresa deveria comunicar em até quinze dias; na sua falta, apenas o próprio acidentado pode emitir a CAT, observado igual prazo.
- (B) A empresa deveria comunicar de imediato; na sua falta, o médico assistente fica impedido de emitir a CAT por sigilo profissional.
- (C) A empresa deveria comunicar até o primeiro dia útil seguinte; na sua falta, o sindicato pode emitir a CAT em até 48 horas.
- (D) A empresa deveria comunicar até o primeiro dia útil seguinte; na falta, o médico assistente pode emitir a CAT, sem prazo.
- (E) A empresa deveria comunicar até o primeiro dia útil seguinte; na sua falta, a CAT só pode ser emitida por ordem judicial.

57. (PER-014 · Avaliação de dano corporal e nexo causal) Em perícia judicial cível, o autor atribui lombociatalgia crônica a colisão traseira de baixa energia ocorrida há dois anos; exames anteriores ao evento já mostravam discopatia multinível. Considerando os critérios médico-legais de nexo causal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O nexo exige apenas a relação cronológica entre o evento e o início dos sintomas, sendo dispensável a análise do estado anterior.
- (B) O nexo exige adequação entre trauma e lesão, coerência topográfica e cronológica e exclusão de causa estranha.
- (C) O nexo é presumido sempre que o periciando apresenta exame de imagem alterado após o evento traumático alegado.
- (D) O nexo exige adequação entre trauma e lesão, sendo a existência de doença prévia suficiente, por si só, para afastá-lo.
- (E) O nexo é estabelecido pelo relato do periciando, cabendo ao perito apenas quantificar o dano decorrente do evento.

58. (PER-015 · Avaliação de dano corporal e nexo causal) Na avaliação do dano corporal, o perito frequentemente identifica fatores que concorrem com o evento principal para o resultado. Assinale a afirmativa CORRETA sobre as concausas.

- (A) As concausas são sempre preexistentes ao evento e, quando presentes, afastam o nexo entre o evento e o resultado.
- (B) As concausas são sempre supervenientes ao evento e transferem integralmente a responsabilidade pelo resultado a terceiros.
- (C) As concausas restringem-se a fatores patológicos do periciando, excluídos fatores externos como infecção hospitalar.
- (D) As concausas só são relevantes no âmbito penal, sendo desconsideradas na perícia previdenciária e trabalhista.
- (E) As concausas podem ser preexistentes, concomitantes ou supervenientes, sem afastar necessariamente o nexo com o evento.

59. (PER-016 · Perícia médica previdenciária) Criança de 6 anos com transtorno do espectro autista, com necessidade de suporte substancial na comunicação e nas atividades diárias, tem pedido de BPC. Considerando a Lei nº 8.742/1993 (LOAS), assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A avaliação verifica impedimento de longo prazo, dispensando-se a análise da renda familiar quando o diagnóstico é confirmado.

(B) A avaliação verifica incapacidade para o trabalho e para a vida independente, sendo inviável o benefício a menores de 16 anos.

(C) A avaliação verifica impedimento de longo prazo em interação com barreiras, sem exigir incapacidade para o trabalho.

(D) A avaliação verifica impedimento de longo prazo, sendo realizada exclusivamente pela perícia médica, sem avaliação social.

(E) A avaliação verifica impedimento de curto prazo, bastando a duração mínima de seis meses para a concessão do benefício.

60. (PER-017 · Perícia médica previdenciária) Considerando o Benefício de Prestação Continuada previsto no art. 20 da Lei nº 8.742/1993, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O benefício garante um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com 60 anos ou mais, exigida contribuição prévia ao RGPS.

(B) O benefício garante um salário mínimo ao idoso com 65 anos ou mais, sendo a pessoa com deficiência atendida pelo RGPS.

(C) O benefício garante um salário mínimo à pessoa com deficiência, desde que comprovada incapacidade total para os atos da vida civil.

(D) O benefício garante meio salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais, cumulável com aposentadoria.

(E) O benefício garante um salário mínimo à pessoa com deficiência e ao idoso de 65 anos ou mais sem meios de se manter.

61. (PER-018 · Bioética aplicada à perícia médica) Perita médica do município é designada para avaliar servidor que ela acompanhou como psiquiatra assistente no ano anterior. Considerando o Código de Ética Médica (Res. CFM nº 2.217/2018), assinale a afirmativa CORRETA.

(A) É permitido ao médico ser perito de seu próprio paciente, pois o conhecimento prévio do caso aumenta a precisão do laudo.

(B) É permitido ao médico ser perito de seu próprio paciente, desde que o periciando concorde por escrito com a avaliação.

(C) É vedado ao médico ser perito de seu próprio paciente apenas na perícia judicial, sendo permitido na perícia administrativa.

(D) É vedado ao médico ser perito de seu próprio paciente apenas enquanto mantido o tratamento, cessando a vedação após a alta.

(E) É vedado ao médico ser perito de seu próprio paciente, devendo a perita declarar-se impedida para a avaliação.

62. (PER-019 · Bioética aplicada à perícia médica) Por sobrecarga de agenda, um perito pretende assinar laudos elaborados por médico residente que examinou os periciandos, sem reexaminá-los. Considerando o Código de Ética Médica, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) É permitido ao médico assinar laudos periciais sem exame pessoal, desde que a autoridade requisitante autorize por escrito.

(B) É permitido ao médico assinar laudos periciais elaborados por terceiro, desde que este seja médico regularmente inscrito no CRM.

(C) É vedado ao médico assinar laudos periciais quando não tenha realizado pessoalmente o exame.

(D) É permitido ao médico assinar laudos periciais sem exame pessoal quando houver documentação médica suficiente nos autos.

(E) É vedado ao médico assinar laudos periciais sem exame pessoal apenas nas perícias criminais de corpo de delito.

63. (PER-020 · Bioética aplicada à perícia médica) Durante perícia, a perita constata que o periciando usa dose de lítio potencialmente tóxica, com tremor grosseiro e confusão mental. Considerando o Código de Ética Médica, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Em regra é vedado ao perito modificar o tratamento, mas pode fazê-lo em urgência, dispensada a comunicação ao médico assistente.

(B) É vedado ao perito modificar o tratamento, mas pode suspender o benefício até que o periciando ajuste a medicação.

(C) É sempre vedado ao perito modificar o tratamento, devendo limitar-se a registrar o achado no laudo, sem outra providência.

(D) Em regra é vedado ao perito modificar o tratamento, salvo urgência, comunicando o fato por escrito ao médico assistente.

(E) É permitido ao perito modificar livremente o tratamento, pois sua função inclui a correção de condutas do médico assistente.

64. (PER-021 · Bioética aplicada à perícia médica) Considerando as vedações do Capítulo XI (Auditoria e Perícia Médica) do Código de Ética Médica, assinale a afirmativa INCORRETA.

(A) É vedado ao perito ultrapassar os limites de suas atribuições e de sua competência.

(B) É vedado ao perito receber remuneração vinculada ao sucesso da causa.

(C) É vedado ao perito assinar laudo sem ter realizado pessoalmente o exame.

(D) É permitido ao perito comentar, diante do examinado, erros do médico assistente.

(E) É vedado ao perito deixar de atuar com absoluta isenção quando designado para a função.

65. (PER-022 · Bioética aplicada à perícia médica) Em perícia judicial previdenciária, o assistente técnico do INSS foi indicado e a parte autora alegou que ele seria suspeito por ser servidor da autarquia. Considerando o CPC, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Os assistentes técnicos são de confiança da parte e assinam o laudo em conjunto com o perito, que o subscreve como revisor.

(B) Os assistentes técnicos são de confiança da parte, mas o perito pode realizar as diligências sem lhes dar ciência prévia.

(C) Os assistentes técnicos são de confiança do juízo e, por isso, devem ser escolhidos entre peritos cadastrados no tribunal.

(D) Os assistentes técnicos são de confiança da parte e não se sujeitam a impedimento ou suspeição.

(E) Os assistentes técnicos sujeitam-se às mesmas causas de impedimento e suspeição do perito, devendo ser substituídos no caso.

66. (PER-023 · Bioética aplicada à perícia médica) No laudo de perícia judicial sobre incapacidade, a perita acrescentou opinião sobre a 'má-fé' do autor e sugeriu ao juiz a improcedência do pedido. Considerando o art. 473 do CPC, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) É dever do perito indicar ao juiz a solução jurídica do pedido, por ser o profissional com conhecimento técnico do caso.

(B) É permitido ao perito ampliar o objeto da perícia quando identificar fatos relevantes, dispensando autorização do juízo.

(C) É permitido ao perito emitir opiniões pessoais sobre a conduta das partes, desde que fundamente em linguagem simples.

(D) É vedado ao perito ultrapassar os limites da designação e emitir opiniões pessoais alheias ao exame técnico.

(E) É vedado ao perito responder a quesitos das partes, devendo limitar-se aos quesitos formulados pelo juiz.

67. (PER-024 · Bioética aplicada à perícia médica) Considerando a valoração da prova pericial pelo juiz, conforme o CPC, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O juiz não está adstrito ao laudo, mas é vedada a determinação de nova perícia sobre a mesma matéria.

(B) O juiz não está adstrito ao laudo e pode afastá-lo sem fundamentação, em razão do livre convencimento.

(C) O juiz está vinculado ao laudo quando não houver impugnação das partes no prazo legal.

(D) O juiz está vinculado às conclusões do laudo, só podendo afastá-las mediante a realização de nova perícia.

(E) O juiz não está adstrito ao laudo, mas deve fundamentar por que acolhe ou afasta suas conclusões.

68. (PER-025 · Bioética aplicada à perícia médica) Médica nomeada perita judicial constatou que é vizinha e amiga íntima do autor. Considerando o CPC, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A escusa pode ser apresentada a qualquer tempo, inclusive após a entrega do laudo, sem consequência processual.

(B) A escusa é dispensada, pois amizade íntima com a parte não configura suspeição aplicável ao perito.

(C) A escusa deve ser apresentada no prazo de 15 dias, mas somente nos casos de impedimento, sendo vedada por suspeição.

(D) A escusa deve ser apresentada em 15 dias da intimação ou da suspeição superveniente, sob pena de renúncia.

(E) A escusa deve ser apresentada no prazo de 5 dias, contado da entrega do laudo, sob pena de nulidade da perícia realizada.

69. (PER-026 · Exame clínico direcionado à perícia médica) Periciando com lombalgia crônica apresenta dor à compressão axial do crânio, à rotação simulada do tronco, Lasègue positivo deitado e negativo sentado, e reação exagerada ao exame. Considerando os sinais de Waddell, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A positividade de qualquer um dos sinais basta para afastar doença orgânica da coluna lombar.

(B) A positividade de três ou mais categorias sugere componente não orgânico, mas não comprova simulação por si só.

(C) A positividade dos sinais deve ser desconsiderada, pois sua aplicação é vedada na perícia previdenciária.

(D) A positividade de três ou mais categorias comprova simulação, autorizando a conclusão de capacidade plena no laudo.

(E) A positividade de três ou mais categorias indica radiculopatia orgânica, devendo ser confirmada por eletroneuromiografia.

70. (PER-027 · Exame clínico direcionado à perícia médica) Periciando refere paresia do membro inferior direito. Ao fletir ativamente o quadril esquerdo contra resistência, a perita sente extensão vigorosa do quadril direito, que antes parecia sem força. Considerando a semiologia pericial, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O achado corresponde ao sinal de Hoover negativo, confirmando a paresia orgânica do membro referido.

(B) O achado corresponde ao sinal de Hoover positivo, indicativo de lesão radicular L5 no membro referido.

- (C) O achado corresponde ao sinal de Hoover positivo, sugestivo de fraqueza funcional do membro referido.
- (D) O achado corresponde ao sinal de Babinski, sugestivo de lesão do neurônio motor superior no membro referido.
- (E) O achado corresponde ao sinal de Romberg, sugestivo de comprometimento da sensibilidade proprioceptiva.

71. (PER-028 · Avaliação pericial em doenças psiquiátricas) Professora com episódio depressivo moderado (CID-10 F32.1), em tratamento há três semanas, apresenta lentificação, prejuízo de concentração e insônia, com ideação passiva de morte. Considerando a avaliação pericial psiquiátrica, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A incapacidade decorre da repercussão funcional dos sintomas sobre a atividade, e não do diagnóstico isolado.
- (B) A incapacidade decorre do diagnóstico de episódio depressivo, que por si só gera afastamento de no mínimo um ano.
- (C) A incapacidade decorre da gravidade do CID informado no atestado, que vincula a conclusão do perito.
- (D) A incapacidade deve ser negada, pois o tratamento iniciado há três semanas indica boa adesão e controle dos sintomas.
- (E) A incapacidade deve ser considerada permanente, pois transtornos depressivos têm curso crônico e recorrente.

72. (PER-029 · Classificação Internacional de Doenças (CID-10/CID-11)) A síndrome de burnout tem sido frequentemente alegada em perícias de servidores. Considerando sua classificação na CID-11, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Na CID-11, o burnout é descrito como fenômeno ocupacional aplicável a qualquer contexto de vida, inclusive o familiar.
- (B) Na CID-11, o burnout (QD85) é fenômeno ocupacional, no capítulo de fatores que influenciam a saúde, e não transtorno mental.
- (C) Na CID-11, o burnout é classificado como transtorno depressivo, no capítulo de transtornos mentais, com código iniciado por 6A.
- (D) Na CID-11, o burnout é classificado como transtorno de ansiedade, exigindo exclusão de causas orgânicas para o diagnóstico.
- (E) Na CID-11, o burnout foi excluído da classificação, por ausência de critérios diagnósticos operacionais.

73. (PER-030 · Avaliação pericial em doenças osteomusculares) Digitadora relata parestesias noturnas em polegar, indicador e médio da mão direita; Phalen e Tinel no punho são positivos e há hipotrofia tenar discreta. Considerando a avaliação pericial, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O quadro sugere síndrome do túnel do carpo, cuja confirmação e graduação se fazem pela eletroneuromiografia.
- (B) O quadro sugere síndrome do túnel do carpo, cuja hipotrofia tenar indica fase inicial e reversível sem tratamento.
- (C) O quadro sugere síndrome do túnel cubital, cuja confirmação se faz pela radiografia simples do cotovelo direito.
- (D) O quadro sugere síndrome do túnel do carpo, sendo o diagnóstico pericial dispensável de correlação com exames complementares.
- (E) O quadro sugere radiculopatia C8, cuja confirmação se faz pela ressonância magnética da coluna cervical.

74. (PER-031 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Considerando as características da perda auditiva induzida por ruído (PAIR) ocupacional, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A PAIR é neurosensorial, em geral bilateral, com entalhe nas frequências de 250 e 500 Hz, poupando as frequências agudas.
- (B) A PAIR é condutiva, em geral unilateral, reversível, com predomínio nas frequências graves, e progride após cessar a exposição.
- (C) A PAIR é neurosensorial, bilateral e simétrica, irreversível, com entalhe em 3, 4 ou 6 kHz, e não progride sem exposição.
- (D) A PAIR é mista, em geral assimétrica, com reversão completa em até seis meses de afastamento do ruído.
- (E) A PAIR é neurosensorial, em geral bilateral e simétrica, mas continua progredindo indefinidamente após cessar a exposição.

75. (PER-032 · Avaliação pericial em doenças respiratórias) Em perícia de ex-marmorista, a espirometria mostra CVF de 62% do previsto e VEF1/CVF de 0,86. Considerando a interpretação funcional respiratória, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O padrão confirma distúrbio obstrutivo grave, pois a relação VEF1/CVF elevada indica limitação ao fluxo aéreo.
- (B) O padrão sugere distúrbio misto, pois a CVF reduzida associada à relação elevada define obstrução e restrição.
- (C) O padrão confirma distúrbio restritivo, sendo dispensável a medida da capacidade pulmonar total.
- (D) O padrão sugere distúrbio restritivo, a ser confirmado pela medida da capacidade pulmonar total.
- (E) O padrão é normal, pois a relação VEF1/CVF acima de 0,70 afasta qualquer distúrbio ventilatório.

76. (PER-033 · Avaliação pericial em doenças cardiovasculares) Segurado com cardiopatia isquêmica, fração de ejeção de 30% e dispneia aos pequenos esforços (classe funcional III da NYHA) requer benefício com isenção de carência. Considerando a avaliação pericial, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A caracterização de cardiopatia grave decorre do diagnóstico de doença isquêmica, independentemente da repercussão funcional.
- (B) A caracterização de cardiopatia grave é atribuição do cardiologista assistente, cujo atestado vincula o perito.
- (C) A caracterização de cardiopatia grave depende apenas da idade do segurado, aplicando-se a partir dos 60 anos.
- (D) A caracterização de cardiopatia grave apoia-se em critérios funcionais e prognósticos, e não no diagnóstico isolado.
- (E) A caracterização de cardiopatia grave exige cirurgia cardíaca prévia, sem a qual não há enquadramento para isenção.

77. (PER-034 · Avaliação pericial em doenças infecciosas) Segurado com HIV, assintomático, carga viral indetectável, trabalhava como cozinheiro em pequena cidade, onde relata discriminação após a revelação do diagnóstico. Considerando a avaliação de incapacidade no âmbito judicial, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Além da condição clínica, deve ser considerada apenas a escolaridade, sendo o estigma social matéria estranha à perícia.
- (B) A ausência de sintomas e a carga viral indetectável afastam qualquer análise de incapacidade, sendo irrelevante o contexto social.
- (C) A ocupação de cozinheiro é incompatível com o HIV por risco de transmissão alimentar, gerando incapacidade técnica.

(D) Além da condição clínica, devem ser consideradas as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais do segurado.

(E) O diagnóstico de HIV gera presunção absoluta de incapacidade total e permanente, dispensando o exame pericial.

78. (PER-035 · Medicina baseada em evidências) Um teste de rastreio tem sensibilidade de 90% e especificidade de 80% e foi aplicado em população com prevalência de 10% da doença. Considerando os conceitos de epidemiologia clínica, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O valor preditivo positivo é de aproximadamente 33%, pois depende também da prevalência da doença.

(B) O valor preditivo positivo é de 90%, pois corresponde à sensibilidade do teste, independentemente da prevalência.

(C) O valor preditivo positivo é de aproximadamente 33%, e aumentaria caso a prevalência da doença fosse menor.

(D) O valor preditivo positivo é de 80%, pois corresponde à especificidade do teste na população estudada.

(E) O valor preditivo positivo é de aproximadamente 67%, pois resulta da média entre sensibilidade e especificidade.

79. (PER-036 · Epidemiologia clínica aplicada à perícia) Em estudo de caso-controle sobre exposição ocupacional à sílica e câncer de pulmão, os pesquisadores precisam estimar a associação. Considerando os desenhos epidemiológicos, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) No estudo de caso-controle, a medida de associação adequada é a razão de chances, que sempre equivale exatamente ao risco relativo.

(B) No estudo de caso-controle, a medida de associação adequada é a razão de chances, pois não se calcula a incidência.

(C) No estudo de caso-controle, a medida de associação adequada é o risco relativo, calculado a partir da incidência nos expostos.

(D) No estudo de caso-controle, a medida de associação adequada é o número necessário para tratar, derivado da redução de risco.

(E) No estudo de caso-controle, a medida de associação adequada é a prevalência, obtida em um único momento no tempo.

80. (PER-037 · Medicina baseada em evidências) Considerando a hierarquia de níveis de evidência em medicina baseada em evidências para questões de terapêutica, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Revisões sistemáticas de ensaios clínicos randomizados de boa qualidade ocupam o topo da hierarquia de evidências terapêuticas.

(B) Estudos transversais ocupam o topo da hierarquia de evidências terapêuticas, por avaliarem grande número de pessoas.

(C) Estudos de caso-controle ocupam o topo da hierarquia de evidências terapêuticas, por permitirem estudar desfechos raros.

(D) Opiniões de especialistas ocupam o topo da hierarquia de evidências terapêuticas, por refletirem a prática clínica.

(E) Relatos e séries de casos ocupam o topo da hierarquia de evidências terapêuticas, por descreverem pacientes reais.

81. (PER-038 · Avaliação pericial em doenças dermatológicas) Auxiliar de enfermagem desenvolve eczema nas mãos que melhora nas férias e piora ao retornar; suspeita-se de alergia à borracha das luvas. Considerando a investigação de dermatoses ocupacionais, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A suspeita de dermatite de contato alérgica é confirmada pela biópsia, sendo o teste de contato contraindicado em trabalhadores.

(B) A suspeita de dermatite de contato irritativa é investigada pelo teste de contato, que é positivo na maioria desses casos.

(C) A suspeita de dermatite de contato alérgica é investigada pelo teste de contato, e a melhora nas férias reforça onexo.

(D) A suspeita de dermatite de contato alérgica dispensa investigação, pois a profissão de saúde basta para o nexo.

(E) A melhora nas férias afasta relação com o trabalho, pois dermatoses ocupacionais persistem mesmo sem exposição.

82. (PER-039 · Avaliação pericial em doenças neurológicas) Servidor de 52 anos teve AVC isquêmico há dois meses, com hemiparesia leve, marcha independente e afasia de expressão em melhora com fonoterapia. Exerce função administrativa. Considerando o prognóstico funcional, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A recuperação neurológica depende apenas da extensão da lesão na imagem, dispensando a avaliação funcional atual.

(B) A recuperação neurológica é imprevisível, impondo aposentadoria imediata a todo servidor com sequela de AVC.

(C) A recuperação neurológica é mais intensa nos primeiros meses, justificando incapacidade temporária com reavaliação.

(D) A recuperação neurológica é irrelevante para a perícia, que deve concluir pela capacidade diante da marcha independente.

(E) A recuperação neurológica se encerra nas primeiras semanas, justificando a conclusão definitiva de incapacidade permanente.

83. (PER-040 · Avaliação pericial em doenças endócrinas e metabólicas) Motorista de ônibus com diabetes tipo 1 apresenta hipoglicemias graves recorrentes, com dois episódios de perda de consciência no último mês. Considerando a avaliação pericial da capacidade, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) As hipoglicemias graves recorrentes geram incapacidade apenas para atividades administrativas, não para a direção.

(B) As hipoglicemias graves recorrentes são irrelevantes para a perícia quando a hemoglobina glicada está dentro da meta.

(C) O diagnóstico de diabetes tipo 1 gera, por si só, incapacidade permanente para qualquer atividade profissional.

(D) O diagnóstico de diabetes tipo 1 é incompatível com a habilitação profissional, impondo cassação definitiva da CNH.

(E) As hipoglicemias graves recorrentes geram incapacidade para a atividade de risco enquanto não houver controle.

84. (PER-041 · Classificação Internacional de Doenças (CID-10/CID-11)) Na emissão de laudos periciais, o correto uso da CID-10 é essencial. Considerando a estrutura dos capítulos da CID-10, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) As doenças do aparelho respiratório são codificadas no capítulo X, com códigos iniciados pela letra R.

(B) Os transtornos mentais e comportamentais são codificados no capítulo V, com códigos iniciados pela letra F.

(C) As doenças do sistema osteomuscular são codificadas no capítulo XIII, com códigos iniciados pela letra S.

- (D) As doenças do aparelho circulatório são codificadas no capítulo IX, com códigos iniciados pela letra C.
- (E) Os transtornos mentais são codificados no capítulo VI, com códigos iniciados pela letra G.

85. (PER-042 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Sandra e Dionísio trabalham em empresas diferentes e fizeram o último exame clínico ocupacional há 100 dias. A empresa de Sandra é de grau de risco 3; a de Dionísio, de grau de risco 2. Ambos serão desligados nesta semana. Considerando a NR 7, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Ambos podem ter o exame demissional dispensado, pois o último exame foi feito há menos de 180 dias.
- (B) Sandra pode ter o exame demissional dispensado, pois o último exame foi feito há menos de 135 dias.
- (C) Dionísio pode ter o exame demissional dispensado, pois o último exame foi feito há menos de 135 dias.
- (D) Nenhum dos dois pode ter o exame dispensado, pois o demissional é obrigatório em qualquer situação.
- (E) Ambos devem repetir o exame, que deve ser feito em até 30 dias após o término do contrato.

86. (PER-043 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Um auxiliar administrativo ficou 45 dias afastado por fratura sofrida em acidente doméstico, sem relação com o trabalho, e vai reassumir a função. Considerando a NR 7, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Ele deve fazer novo exame admissional, pois o afastamento superior a 30 dias suspende o contrato de trabalho.
- (B) Ele deve fazer o exame de retorno antes de reassumir a função, e o médico deve definir se o retorno será gradativo.
- (C) Ele deve fazer o exame de retorno em até 30 dias após reassumir a função, conforme a agenda do PCMSO.
- (D) Ele fica dispensado do exame de retorno, pois este só é exigido após afastamento por doença ocupacional.
- (E) Ele só fará exame de retorno se o afastamento tiver ultrapassado 60 dias, prazo fixado pela NR 7.

87. (PER-044 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Segundo a NR 7, no controle médico de trabalhadores expostos a níveis de pressão sonora elevados, a periodicidade mínima do exame audiométrico é:

- (A) Na admissão e a cada dois anos durante a exposição.
- (B) Na admissão, a cada cinco anos e na demissão.
- (C) Na admissão e na demissão, apenas.
- (D) Somente quando o trabalhador relatar queixa auditiva.
- (E) Na admissão, anualmente e na demissão.

88. (PER-045 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Sobre o Atestado de Saúde Ocupacional (ASO) e o PCMSO, conforme a NR 7, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O ASO deve informar o diagnóstico do trabalhador pela CID, para que o empregador possa organizar a função.
- (B) O ASO deve indicar os exames realizados e as datas em que foram feitos.
- (C) O ASO deve conter a definição de apto ou inapto para a função específica que o empregado exerce.
- (D) O PCMSO tem por objetivo proteger e preservar a saúde dos empregados em relação aos riscos ocupacionais.
- (E) O ASO deve trazer o nome e o número de registro profissional do médico que fez o exame clínico.

89. (PER-046 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Conforme a NR 15, a exposição acima do limite de tolerância às radiações ionizantes e ao calor caracteriza, respectivamente, insalubridade de grau:

- (A) médio e mínimo.
- (B) médio e máximo.
- (C) máximo e máximo.
- (D) mínimo e médio.
- (E) máximo e médio.

90. (PER-047 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Na caracterização da insalubridade pela NR 15, alguns agentes são avaliados por limite de tolerância (critério quantitativo) e outros por inspeção no local de trabalho (critério qualitativo). Assinale a alternativa que apresenta, respectivamente, um agente quantitativo e um qualitativo.

- (A) Vibração e umidade.
- (B) Frio e calor.
- (C) Umidade e agentes biológicos.
- (D) Agentes biológicos e radiação ionizante.
- (E) Umidade e ruído contínuo.

91. (PER-048 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Pela NR 15, o limite de tolerância para ruído contínuo ou intermitente de 85 dB(A) permite exposição diária máxima de:

- (A) 12 horas.
- (B) 6 horas.
- (C) 4 horas.
- (D) 8 horas.
- (E) 2 horas.

92. (PER-049 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Um trabalhador de fundição fica exposto acima dos limites a ruído (grau médio) e a poeira mineral de sílica (grau máximo). Sobre o adicional de insalubridade, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Recebe a soma dos dois adicionais, pois cada agente gera direito autônomo.
- (B) Não recebe adicional se usar EPI, ainda que o equipamento não neutralize a exposição.
- (C) Recebe a média dos dois adicionais, calculada sobre o salário contratual.
- (D) Recebe apenas o adicional do grau médio, pois o ruído é o agente avaliado primeiro.
- (E) Recebe apenas o adicional do grau mais elevado, pois os adicionais não se somam.

93. (PER-050 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Conforme a NR 1, o Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) deve conter, no mínimo, os seguintes documentos:

- (A) o inventário de riscos e o plano de ação.
- (B) o PCMSO e o laudo de insalubridade.
- (C) a CAT e o mapa de riscos da CIPA.
- (D) o plano de ação e a ficha de entrega de EPI.
- (E) o inventário de riscos e o ASO de cada empregado.

94. (PER-051 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Sobre as medidas de proteção da NR 32, que trata da segurança e saúde no trabalho em serviços de saúde, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É vedado o uso de calçados abertos pelos trabalhadores expostos a agentes biológicos.
- (B) É vedado o uso de adornos nos postos de trabalho com exposição a agentes biológicos.
- (C) É permitido reencapar agulhas usadas quando o trabalhador usar luvas de procedimento.
- (D) É vedado consumir alimentos e bebidas nos postos de trabalho com exposição a agentes biológicos.
- (E) O empregador deve oferecer gratuitamente vacinação contra tétano, difteria e hepatite B.

95. (PER-052 · Doenças ocupacionais e relacionadas ao trabalho) Conforme o anexo da NR 17 sobre trabalho em teleatendimento/telemarketing, o tempo de trabalho em efetiva atividade de atendimento, nele incluídas as pausas e sem prejuízo da remuneração, é de, no máximo:

- (A) 8 horas diárias, com duas pausas de 10 minutos.
- (B) 6 horas diárias.
- (C) 7 horas diárias, sem pausas obrigatórias.
- (D) 4 horas diárias.
- (E) 44 horas semanais, distribuídas livremente.

96. (PER-053 · Avaliação de dano corporal e nexo causal) Na classificação de Schilling das doenças relacionadas ao trabalho, assinale a alternativa que associa CORRETAMENTE o grupo ao exemplo.

- (A) Grupo II (trabalho como fator contributivo): silicose e asbestose.
- (B) Grupo I (trabalho como causa necessária): doença coronariana e varizes de membros inferiores.
- (C) Grupo III (trabalho como provocador ou agravante): intoxicação por chumbo e silicose.
- (D) Grupo III (trabalho como provocador ou agravante): câncer de pulmão em trabalhador exposto ao asbesto.
- (E) Grupo I (trabalho como causa necessária): silicose e intoxicação por chumbo.

97. (PER-054 · Avaliação pericial em doenças respiratórias) Sobre as pneumoconioses e a avaliação das doenças respiratórias ocupacionais, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A asbestose cessa a progressão com o afastamento da exposição, o que dispensa acompanhamento.
- (B) A radiografia de tórax pela classificação da OIT é o exame de referência para rastrear silicose e asbestose.
- (C) A espirometria normal descarta pneumoconiose, dispensando a radiografia de tórax.
- (D) A silicose acomete preferencialmente os lobos inferiores, enquanto a asbestose predomina nos lobos superiores.
- (E) A asma ocupacional é uma pneumoconiose, e o exame mais indicado para o diagnóstico é a radiografia de tórax.

98. (PER-055 · Avaliação pericial em doenças psiquiátricas) Sobre o transtorno de estresse pós-traumático (TEPT) na avaliação de trabalhador vítima de assalto em serviço, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O diagnóstico dispensa a exposição a evento traumático quando há sintomas de revivescência.
- (B) O TEPT impede o nexo com o trabalho quando o evento ocorre no trajeto ou fora do posto de trabalho.
- (C) Os sintomas surgem obrigatoriamente logo após o trauma, sem período de latência.
- (D) Os sintomas podem surgir após um período de latência de semanas a meses depois do evento traumático.

(E) A presença de revivescências é suficiente, por si só, para concluir pela incapacidade laboral permanente.

99. (PER-056 · Perícia médica previdenciária) Um segurado empregado, com 8 anos de contribuição ininterrupta ao RGPS, foi demitido e não voltou a contribuir. Considerando o art. 15 da Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Mantém a qualidade de segurado por até 24 meses, porque já pagou mais de 120 contribuições.
- (B) Perde a qualidade de segurado no mês seguinte ao da última contribuição.
- (C) Mantém a qualidade de segurado sem limite de prazo, por ter contribuído mais de 5 anos.
- (D) Mantém a qualidade de segurado por apenas 6 meses, prazo próprio do segurado facultativo.
- (E) Mantém a qualidade de segurado por até 12 meses, prazo acrescido de 12 meses se comprovar o desemprego.

100. (PER-057 · Perícia médica previdenciária) Sobre a manutenção da qualidade de segurado do RGPS, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) O segurado acometido de doença de segregação compulsória mantém a qualidade por até 12 meses após cessar a segregação.
- (B) O período de graça do empregado pode ser acrescido de 12 meses se ele comprovar o desemprego.
- (C) Mantém a qualidade de segurado, sem limite de prazo, quem está em gozo de auxílio por incapacidade temporária.
- (D) O segurado facultativo mantém a qualidade de segurado por até 6 meses após cessar as contribuições.
- (E) Mantém a qualidade de segurado, sem limite de prazo, quem recebe o benefício de prestação continuada (BPC/LOAS).

101. (PER-058 · Perícia médica previdenciária) Segurado que perdeu a qualidade de segurado volta a contribuir e, meses depois, fica incapaz por lombociatalgia, doença que não isenta de carência. Considerando o art. 27-A da Lei nº 8.213/1991, para aproveitar as contribuições anteriores ao auxílio por incapacidade temporária ele precisa contar, a partir da nova filiação, com:

- (A) 6 contribuições mensais, metade da carência exigida.
- (B) 24 contribuições mensais, o dobro da carência, como penalidade pela perda da qualidade.
- (C) 4 contribuições mensais, um terço da carência exigida.
- (D) 12 contribuições mensais, a carência integral exigida.
- (E) nenhuma contribuição, pois as contribuições anteriores são computadas de imediato.

102. (PER-059 · Perícia médica previdenciária) Sobre a garantia de emprego do segurado que sofreu acidente do trabalho, prevista no art. 118 da Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A garantia começa na data do acidente e dura 12 meses, mesmo sem afastamento previdenciário.
- (B) A garantia é de, no mínimo, 12 meses após cessar o auxílio-doença acidentário, independentemente de auxílio-acidente.
- (C) A garantia depende de o segurado passar a receber auxílio-acidente após a alta.
- (D) A garantia é de, no máximo, 12 meses após cessar o auxílio-doença acidentário.
- (E) A garantia alcança qualquer afastamento previdenciário, ainda que a doença não tenha relação com o trabalho.

103. (PER-060 · Perícia médica previdenciária) Metalúrgico com PAIR leve e bilateral, de nexo ocupacional reconhecido, continua exercendo a mesma função sem limitação comprovada. Ele requer auxílio-acidente.

Considerando a Lei nº 8.213/1991, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Não faz jus ao benefício, pois a perda auditiva só gera auxílio-acidente se reduzir a capacidade para o trabalho habitual.
- (B) Faz jus ao benefício, pois qualquer grau de perda auditiva ocupacional gera auxílio-acidente.
- (C) Faz jus ao benefício, pois basta o nexo causal reconhecido, dispensando avaliação da capacidade.
- (D) Não faz jus ao benefício, pois a PAIR é doença degenerativa e não é considerada doença do trabalho.
- (E) Não faz jus ao benefício, pois o auxílio-acidente exige perda auditiva total e bilateral.

104. (PER-061 · Perícia médica previdenciária) Sobre o benefício de prestação continuada (BPC) da Lei nº 8.742/1993 (LOAS), assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Exige incapacidade para o trabalho igual à do auxílio por incapacidade temporária.
- (B) Pode ser acumulado com aposentadoria do RGPS, desde que a renda familiar permaneça baixa.
- (C) Deve ser revisto a cada 2 anos para avaliar a continuidade das condições que lhe deram origem.
- (D) Exige carência de 12 contribuições e qualidade de segurado na data do requerimento.
- (E) Gera pensão por morte aos dependentes do beneficiário falecido.

105. (PER-062 · Avaliação de invalidez e incapacidade permanente) Servidor ativo, em plena atividade, tem diagnóstico de neoplasia maligna em tratamento e pede ao perito laudo para isenção do imposto de renda prevista na Lei nº 7.713/1988 (art. 6º, XIV). Assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A isenção alcança a remuneração do servidor ativo, bastando o laudo de doença grave.
- (B) A isenção vale para qualquer doença crônica, a critério do perito, desde que haja tratamento contínuo.
- (C) A isenção alcança proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, e não a remuneração da atividade.
- (D) A isenção exige incapacidade total e permanente para qualquer trabalho.
- (E) A isenção exige que a neoplasia tenha relação com o trabalho, por se tratar de moléstia profissional.

106. (PER-063 · Bioética aplicada à perícia médica) O gerente de uma empresa pede ao médico do trabalho o diagnóstico que motivou o atestado de um empregado, alegando necessidade de 'planejar a equipe'. Não há risco à saúde de outros empregados nem da comunidade. Conforme o Código de Ética Médica, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O médico pode revelar o diagnóstico verbalmente, desde que não o registre por escrito.
- (B) O médico deve revelar apenas o código da CID, que não identifica a doença para leigos.
- (C) O médico não deve revelar o diagnóstico, pois a exigência da empresa não afasta o sigilo.
- (D) O médico deve revelar o diagnóstico, pois foi contratado pela empresa e a ela deve lealdade.
- (E) O médico pode revelar o diagnóstico se o gerente assinar termo de confidencialidade.

107. (PER-064 · Bioética aplicada à perícia médica) Considerando as vedações do Código de Ética Médica ao médico que atua como perito ou auditor, assinale a alternativa INCORRETA.

- (A) É vedado ao médico ser perito do próprio paciente ou de pessoa de sua família.
- (B) O perito pode receber honorários proporcionais ao valor obtido pela parte vencedora da causa.
- (C) É vedado ao perito assinar laudo pericial sem ter realizado pessoalmente o exame.
- (D) É vedado ao perito deixar de atuar com absoluta isenção quando designado.
- (E) É vedado ao perito, salvo urgência, modificar procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos.

108. (PER-065 · Bioética aplicada à perícia médica) Conforme o art. 473 do Código de Processo Civil, o laudo pericial deve conter os itens abaixo, EXCETO:

- (A) opinião pessoal do perito sobre questões jurídicas que ultrapassem o exame técnico do objeto da perícia.
- (B) indicação do método utilizado, demonstrando ser predominantemente aceito pelos especialistas.
- (C) resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo Ministério Público.
- (D) análise técnica ou científica realizada pelo perito.
- (E) exposição do objeto da perícia.

109. (PER-066 · Avaliação da capacidade laborativa) Caixa de supermercado de 61 anos, com cardiopatia chagásica e marca-passo, comparece à perícia no 22º dia de atestado de 30 dias, referindo dispneia ao banho. Ao exame, está compensado em repouso. Sobre a conduta pericial, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A conclusão deve ser pela incapacidade permanente, pois cardiopatia chagásica com marca-passo é sempre incapacitante.
- (B) A conclusão depende da correlação entre achados, gravidade funcional e exigências da função habitual.
- (C) A conclusão deve seguir o atestado do médico assistente, que vincula o perito quanto ao prazo.
- (D) A conclusão deve incluir prescrição de novo fármaco, conduta que cabe ao perito ao identificar tratamento insuficiente.
- (E) A conclusão deve ser pela capacidade, pois o exame em repouso normal afasta a dispneia relatada.

SUS

110. (SUS-001 · CF/88 arts. 196 a 200) Durante reunião do Conselho Municipal de Saúde, um conselheiro defendeu que, por ser a saúde um 'direito de todos', a obrigação do município se esgotaria na oferta de consultas e exames na rede própria. Considerando o art. 196 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A saúde deve ser garantida por políticas sociais e econômicas que reduzam o risco de doença e assegurem acesso universal e igualitário.
- (B) A saúde deve ser garantida por ações de recuperação, cabendo a promoção e a proteção exclusivamente à política de assistência social.
- (C) A saúde deve ser garantida prioritariamente pela oferta assistencial, cabendo às políticas econômicas papel apenas acessório e eventual no setor.
- (D) A saúde deve ser garantida com acesso universal, mas o acesso igualitário restringe-se aos usuários previamente cadastrados na atenção primária.
- (E) A saúde deve ser garantida exclusivamente pelo Estado, sendo vedada a participação da iniciativa privada na execução das ações e serviços.

111. (SUS-002 · CF/88 arts. 196 a 200) Um município contratou clínica privada para realizar exames de imagem para usuários do SUS. Um vereador sustentou que, sendo privada a executora, o serviço deixaria de se submeter ao controle do Poder Público. Considerando o art. 197 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) As ações e serviços de saúde passam a ser de interesse privado quando executados por terceiros, afastando a fiscalização do Poder Público.
- (B) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, cabendo ao Poder Público regulamentá-los, fiscalizá-los e controlá-los.
- (C) As ações e serviços de saúde são de relevância pública somente quando prestados gratuitamente, dispensando-se o controle nos demais casos.

(D) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, razão pela qual sua execução deve ocorrer exclusivamente pela administração direta.

(E) As ações e serviços de saúde são de relevância pública, mas sua regulamentação compete apenas à União, vedada a atuação municipal.

112. (SUS-003 · CF/88 arts. 196 a 200) As ações e serviços públicos de saúde integram uma rede regionalizada e hierarquizada e constituem um sistema único, organizado de acordo com diretrizes constitucionais. Considerando o art. 198 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O SUS organiza-se com descentralização, mantendo direção compartilhada entre as esferas dentro de cada nível de governo.

(B) O SUS organiza-se com atendimento integral, priorizando atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais.

(C) O SUS organiza-se com participação da comunidade, de natureza apenas consultiva nas instâncias colegiadas de gestão.

(D) O SUS organiza-se em rede centralizada e hierarquizada, com o comando operacional das ações exercido pela União.

(E) O SUS organiza-se com atendimento integral, priorizando os serviços assistenciais em detrimento das atividades preventivas.

113. (SUS-004 · Financiamento) O secretário de Finanças de Porto Calvo questiona qual é o percentual mínimo que o município deve aplicar anualmente em ações e serviços públicos de saúde. Considerando a CF/88 e a LC nº 141/2012, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O Município deve aplicar, no mínimo, 15% da receita corrente líquida, mesma base de cálculo adotada para a União na Constituição.

(B) O Município deve aplicar, no mínimo, 10% da arrecadação de impostos, podendo compensar o restante com recursos federais recebidos.

(C) O Município deve aplicar, no mínimo, 12% da arrecadação dos impostos próprios e das transferências previstas na LC nº 141/2012.

(D) O Município deve aplicar, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos próprios e das transferências constitucionais previstas na LC nº 141/2012.

(E) O Município deve aplicar, no mínimo, 25% da arrecadação de impostos, percentual idêntico ao exigido para a manutenção do ensino.

114. (SUS-005 · CF/88 arts. 196 a 200) Um hospital privado com fins lucrativos pleiteou subvenção municipal para reformar sua UTI, comprometendo-se a atender pacientes do SUS. Considerando o art. 199 da Constituição Federal, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) É vedada a contratação de instituições privadas pelo SUS, admitindo-se somente convênios com entidades da administração pública.

(B) É vedada a destinação de recursos públicos para auxílios ou subvenções às instituições privadas com fins lucrativos.

(C) É vedada a participação de entidades filantrópicas no SUS, uma vez que recebem recursos públicos sob a forma de isenção.

(D) É permitida a participação direta de capital estrangeiro na assistência à saúde, independentemente de previsão em lei.

(E) É permitida a subvenção a instituições privadas com fins lucrativos, desde que aprovada previamente pelo Conselho Municipal de Saúde.

115. (SUS-006 · CF/88 arts. 196 a 200) O art. 200 da Constituição Federal enumera atribuições do Sistema Único de Saúde, além de outras previstas em lei. Assinale a afirmativa INCORRETA.

- (A) Compete ao SUS colaborar na proteção do meio ambiente, nele compreendido o do trabalho.
- (B) Compete ao SUS fiscalizar e inspecionar alimentos, compreendido o controle de seu teor nutricional.
- (C) Compete ao SUS ordenar a formação de recursos humanos na área de saúde.
- (D) Compete ao SUS executar as ações de vigilância sanitária e epidemiológica, bem como as de saúde do trabalhador.
- (E) Compete ao SUS formular e executar com exclusividade a política de saneamento básico.

116. (SUS-007 · Lei nº 8.080/1990) Uma equipe de Saúde da Família observou aumento de doenças diarreicas em área sem rede de esgoto e com baixa renda familiar, e levou o caso à gestão municipal. Considerando os arts. 2º e 3º da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Os níveis de saúde dependem exclusivamente da oferta de serviços médicos, sendo o saneamento tema alheio às políticas de saúde.
- (B) Os níveis de saúde decorrem de fatores biológicos individuais, razão pela qual o dever do Estado dispensa ações intersetoriais.
- (C) Os níveis de saúde são responsabilidade apenas do Estado, o que exclui o dever das pessoas, da família, das empresas e da sociedade.
- (D) Os níveis de saúde expressam a organização social, mas o trabalho e a renda não são reconhecidos como condicionantes pela lei.
- (E) Os níveis de saúde expressam a organização social e econômica, tendo o saneamento e a renda entre seus condicionantes.

117. (SUS-008 · Lei nº 8.080/1990) Considerando o conceito legal de Sistema Único de Saúde previsto no art. 4º da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O SUS é constituído por ações e serviços de órgãos federais, cabendo aos entes subnacionais apenas a execução delegada.
- (B) O SUS é constituído por ações e serviços públicos e privados, integrando a iniciativa privada o sistema em caráter obrigatório.
- (C) O SUS é constituído por ações e serviços públicos, excluídas as fundações mantidas pelo Poder Público por terem personalidade própria.
- (D) O SUS é constituído por ações e serviços públicos, e a iniciativa privada poderá substituí-lo quando o custo for menor.
- (E) O SUS é constituído por ações e serviços públicos de saúde, e a iniciativa privada poderá participar dele em caráter complementar.

118. (SUS-009 · Lei nº 8.080/1990) Fiscais municipais inspecionaram uma padaria após denúncias de alimentos armazenados em condições inadequadas, apreendendo produtos vencidos. Considerando o art. 6º da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Trata-se de vigilância sanitária, cujo alcance se restringe aos serviços de saúde, excluídos os alimentos comercializados.
- (B) Trata-se de ação de saúde do trabalhador, pois a inspeção recai sobre estabelecimento comercial que emprega pessoas.
- (C) Trata-se de vigilância epidemiológica, por envolver o controle de produtos e de serviços de interesse da saúde da população.

(D) Trata-se de vigilância sanitária, que busca eliminar, diminuir ou prevenir riscos da produção e circulação de bens.

(E) Trata-se de vigilância ambiental, atribuída com exclusividade ao órgão estadual de meio ambiente pela legislação do SUS.

119. (SUS-010 · Lei nº 8.080/1990) Após aumento de notificações de dengue em dois bairros, a Secretaria Municipal de Saúde investigou os casos, mapeou fatores condicionantes e recomendou medidas de controle. Considerando o art. 6º da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Trata-se de vigilância sanitária, que proporciona o conhecimento e a detecção de mudanças nos fatores condicionantes, para recomendar medidas de controle.

(B) Trata-se de vigilância epidemiológica, cuja execução compete exclusivamente à União, cabendo ao município apenas notificar.

(C) Trata-se de vigilância epidemiológica, que detecta mudanças nos fatores condicionantes para recomendar medidas de controle.

(D) Trata-se de assistência terapêutica integral, uma vez que a investigação dos casos pressupõe o tratamento individual dos doentes.

(E) Trata-se de vigilância epidemiológica, cuja finalidade se limita ao registro estatístico dos casos, sem recomendar medidas de controle.

120. (SUS-011 · Lei nº 8.080/1990) Paciente diabético acompanhado na UBS foi encaminhado à oftalmologia por retinopatia, retornando à equipe de referência com plano de cuidado compartilhado. Considerando os princípios do art. 7º da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A integralidade é entendida como acesso igualitário à assistência, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.

(B) A integralidade é entendida como prioridade das ações curativas individuais, ficando as coletivas a cargo da vigilância em saúde.

(C) A integralidade é entendida como conjunto articulado e contínuo de ações preventivas e curativas, individuais e coletivas.

(D) A integralidade é entendida como garantia de acesso aos serviços em todos os níveis, independentemente de articulação ou continuidade.

(E) A integralidade é entendida como oferta de todos os procedimentos em uma única unidade, dispensando a articulação entre os níveis de atenção.

121. (SUS-012 · Lei nº 8.080/1990) A Lei nº 8.080/1990 estabelece, entre os princípios do SUS, a descentralização político-administrativa. Assinale a afirmativa CORRETA sobre esse princípio.

(A) A descentralização ocorre com direção compartilhada entre as esferas, cabendo à União a gestão direta dos serviços locais.

(B) A descentralização ocorre apenas no plano financeiro, mantendo-se centralizadas na União as decisões sobre a organização dos serviços.

(C) A descentralização ocorre com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na descentralização dos serviços para os municípios.

(D) A descentralização ocorre com direção única em cada esfera de governo, com ênfase na concentração dos serviços nos estados.

(E) A descentralização ocorre com transferência integral de responsabilidades aos municípios, dispensando a regionalização e a hierarquização.

122. (SUS-013 · Lei nº 8.080/1990) Ao elaborar a programação anual, a gestora municipal utilizou dados de mortalidade e morbidade para definir prioridades e distribuir recursos entre as unidades. Considerando os

princípios do art. 7º da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A conduta concretiza o princípio da utilização da epidemiologia, que se restringe à vigilância e não orienta a alocação de recursos.

(B) A conduta concretiza o princípio da utilização da epidemiologia para definir prioridades, alocar recursos e orientar a programação.

(C) A conduta concretiza o princípio da participação da comunidade, já que dados de morbidade substituem a deliberação do Conselho.

(D) A conduta viola o princípio da igualdade da assistência, pois priorizar territórios por dados epidemiológicos cria privilégios.

(E) A conduta concretiza o princípio da universalidade, pois o uso de dados epidemiológicos assegura acesso a todos os níveis de atenção.

123. (SUS-014 · Gestão municipal do SUS) Conforme o art. 9º da Lei nº 8.080/1990, a direção do SUS é única e exercida, em cada esfera de governo, por órgão específico. Assinale a afirmativa CORRETA quanto ao âmbito municipal.

(A) No âmbito dos municípios, a direção do SUS é exercida pela respectiva Secretaria de Saúde ou órgão equivalente.

(B) No âmbito dos municípios, a direção do SUS é exercida pela Comissão Intergestores Bipartite, em conjunto com o prefeito.

(C) No âmbito dos municípios, a direção do SUS é exercida pelo Conselho Municipal de Saúde, em caráter permanente e deliberativo.

(D) No âmbito dos municípios, a direção do SUS é exercida pela Secretaria Estadual de Saúde, por meio de suas regionais.

(E) No âmbito dos municípios, a direção do SUS é exercida pelo Ministério da Saúde, mediante delegação ao prefeito municipal.

124. (SUS-015 · Gestão municipal do SUS) A Lei nº 8.080/1990 distribui competências entre as direções nacional, estadual e municipal do SUS. Assinale a afirmativa CORRETA quanto a competência da direção MUNICIPAL.

(A) Compete à direção municipal estabelecer normas e executar a vigilância sanitária de portos, aeroportos e fronteiras do país.

(B) Compete à direção municipal executar os serviços de vigilância epidemiológica e sanitária e de saúde do trabalhador.

(C) Compete à direção municipal formular, avaliar e apoiar as políticas de alimentação e nutrição em âmbito nacional.

(D) Compete à direção municipal definir e coordenar os sistemas de redes integradas de assistência de alta complexidade em âmbito nacional.

(E) Compete à direção municipal promover a descentralização para os municípios dos serviços e das ações de saúde do estado.

125. (SUS-016 · Gestão municipal do SUS) O município pretende ampliar a oferta de fisioterapia contratando clínicas privadas e precisa definir quem celebra os contratos e acompanha sua execução. Considerando a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Compete à direção municipal celebrar contratos e convênios com prestadores privados, bem como controlar e avaliar sua execução.

(B) Compete à direção municipal celebrar contratos com prestadores privados, ficando o controle da execução a cargo do Conselho de Saúde.

(C) Compete à direção municipal celebrar contratos com prestadores privados, desde que estes renunciem à fiscalização municipal.

(D) Compete à direção estadual celebrar contratos com prestadores privados situados no município, cabendo a este apenas indicar a demanda.

(E) Compete ao Ministério da Saúde celebrar contratos com prestadores privados, por ser a direção nacional responsável pela remuneração.

126. (SUS-017 · Gestão municipal do SUS) Considerando as competências da direção ESTADUAL do SUS previstas no art. 17 da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) Compete à direção estadual celebrar contratos com prestadores privados de cada município, controlando sua execução.

(B) Compete à direção estadual definir, em caráter exclusivo, as normas nacionais de vigilância sanitária de portos e aeroportos.

(C) Compete à direção estadual prestar apoio técnico aos municípios, sendo-lhe vedado o apoio financeiro às gestões locais.

(D) Compete à direção estadual executar diretamente a atenção primária em todos os municípios, substituindo a gestão local.

(E) Compete à direção estadual prestar apoio técnico e financeiro aos municípios e executar supletivamente ações de saúde.

127. (SUS-018 · Gestão municipal do SUS) A Lei nº 8.080/1990, com redação da Lei nº 12.466/2011, reconhece as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite. Assinale a afirmativa CORRETA sobre essas comissões.

(A) As comissões intergestores são foros de negociação e pactuação entre gestores quanto aos aspectos operacionais do SUS.

(B) As comissões intergestores são órgãos de direção do SUS, substituindo as secretarias de saúde nas decisões executivas.

(C) As comissões intergestores são instâncias de controle social, com participação paritária de usuários e prestadores de serviço.

(D) As comissões intergestores são foros de fiscalização dos prestadores privados, com poder de aplicar sanções contratuais.

(E) As comissões intergestores são foros de pactuação entre gestores, cujas decisões dependem de homologação pelo Poder Legislativo.

128. (SUS-019 · Lei nº 8.080/1990) Diante de filas para cirurgias eletivas, o município decidiu contratar serviços privados. Duas entidades se apresentaram: uma filantrópica e uma empresa com fins lucrativos. Considerando os arts. 24 a 26 da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A contratação é possível quando a rede for insuficiente, cabendo ao município fixar livremente os valores de remuneração.

(B) A contratação é possível se a rede for insuficiente, com preferência às entidades filantrópicas e sem fins lucrativos.

(C) A contratação é vedada à empresa com fins lucrativos, que não pode participar do SUS sob nenhuma forma.

(D) A contratação é possível independentemente da capacidade da rede pública, com preferência à proposta de menor preço.

(E) A contratação é possível quando a rede for insuficiente, dispensando os contratados de observar os princípios do SUS.

129. (SUS-020 · Financiamento) Considerando a gestão financeira prevista na Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA sobre a movimentação dos recursos financeiros do SUS.

- (A) Os recursos são depositados em conta especial apenas na esfera federal, sendo transferidos aos municípios sem vinculação.
- (B) Os recursos são depositados na conta única do Tesouro municipal, sendo movimentados livremente pelo prefeito.
- (C) Os recursos são depositados em conta especial e movimentados sob fiscalização exclusiva do Tribunal de Contas da União.
- (D) Os recursos são depositados em conta especial em cada esfera e movimentados sob fiscalização dos Conselhos de Saúde.
- (E) Os recursos são depositados em conta especial, cabendo ao Conselho de Saúde executá-los diretamente em substituição ao gestor.

130. (SUS-021 · Gestão municipal do SUS) Considerando o processo de planejamento e orçamento do SUS previsto no art. 36 da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O planejamento é ascendente, do nível local até o federal, dispensada a oitiva dos conselhos quando houver urgência orçamentária.
- (B) O planejamento é ascendente, do nível local ao federal, ouvidos os órgãos deliberativos e compatibilizado com os recursos.
- (C) O planejamento é descendente, do nível federal até o local, cabendo aos municípios executar as metas definidas pela União.
- (D) O planejamento é ascendente, desconsiderando a disponibilidade de recursos para não limitar as necessidades da população.
- (E) O planejamento é ascendente, mas restrito ao nível estadual, ao qual cabe consolidar e aprovar os planos municipais.

131. (SUS-022 · Lei nº 8.080/1990) Em maternidade conveniada ao SUS, a equipe impediu a entrada do acompanhante de uma parturiente durante o trabalho de parto, alegando que o acompanhante só seria permitido após o nascimento. Considerando a Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A parturiente tem direito a um acompanhante de sua escolha durante o trabalho de parto, o parto e o pós-parto imediato.
- (B) A parturiente tem direito a um acompanhante apenas no pós-parto imediato, a critério da equipe assistencial do serviço.
- (C) A parturiente tem direito a acompanhante somente em serviços próprios do SUS, não alcançando a rede conveniada.
- (D) A parturiente tem direito a um acompanhante durante o trabalho de parto, sendo-lhe vedada a presença na sala de parto.
- (E) A parturiente tem direito a um acompanhante durante o parto, desde que seja parente de primeiro grau indicado pela equipe.

132. (SUS-023 · Lei nº 8.080/1990) Uma sociedade médica solicitou a incorporação de um novo medicamento ao SUS. Considerando os arts. 19-Q e 19-R da Lei nº 8.080/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A incorporação é atribuição de cada Secretaria Estadual, assessorada pela CONITEC, conforme a necessidade regional apurada.
- (B) A incorporação é atribuição do Ministério da Saúde, sendo dispensado o registro prévio do medicamento na ANVISA.

(C) A incorporação é atribuição da ANVISA, assessorada pela CONITEC, devendo o processo ser concluído em até 180 dias, prorrogáveis por 90.

(D) A incorporação é atribuição do Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, devendo o processo ser concluído em até 90 dias, improrrogáveis.

(E) A incorporação cabe ao Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC, em processo de até 180 dias, prorrogáveis por 90.

133. (SUS-024 · Controle social) A Lei nº 8.142/1990 institui instâncias colegiadas em cada esfera de governo. Assinale a afirmativa CORRETA sobre a Conferência de Saúde.

(A) A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos, com representação dos segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde.

(B) A Conferência de Saúde reúne-se em caráter permanente, com função deliberativa sobre a execução orçamentária mensal do fundo.

(C) A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos, com participação restrita a gestores e prestadores de serviços de saúde.

(D) A Conferência de Saúde reúne-se a cada dois anos, com representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor diretrizes.

(E) A Conferência de Saúde reúne-se a cada quatro anos, sendo convocada exclusivamente pelo Conselho de Saúde da respectiva esfera.

134. (SUS-025 · Controle social) O Conselho Municipal de Saúde aprovou resolução sobre a reorganização da rede de atenção, mas o secretário afirmou que o colegiado seria apenas consultivo. Considerando a Lei nº 8.142/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O Conselho tem caráter deliberativo, mas sua atuação exclui os aspectos econômicos e financeiros da política de saúde.

(B) O Conselho tem caráter permanente e deliberativo, e suas decisões são homologadas pelo chefe do poder em cada esfera.

(C) O Conselho tem caráter temporário e consultivo, e suas decisões dependem de referendo da Conferência Municipal de Saúde.

(D) O Conselho tem caráter permanente e deliberativo, e suas decisões produzem efeitos imediatos, dispensada a homologação.

(E) O Conselho tem caráter permanente e consultivo, atuando apenas na formulação de estratégias, sem controlar a execução.

135. (SUS-026 · Controle social) O Conselho Municipal de Saúde de um município alagoano terá 24 conselheiros titulares. Considerando a Lei nº 8.142/1990 e a Resolução CNS nº 453/2012, assinale a afirmativa CORRETA sobre sua composição.

(A) Devem ser 12 representantes de usuários, sendo admitida a indicação de servidores da secretaria nessa vaga.

(B) Devem ser 8 representantes de usuários, 8 de trabalhadores e 8 de gestores e prestadores, em divisão igualitária por terços.

(C) Devem ser 6 representantes de usuários, cabendo a maioria aos trabalhadores, por deterem conhecimento técnico.

(D) Devem ser 12 representantes de usuários e 12 dos demais segmentos (trabalhadores, gestores e prestadores).

(E) Devem ser 12 representantes de gestores, em razão de sua responsabilidade legal pela execução da política.

136. (SUS-027 · Financiamento) Auditoria constatou que um município não instituiu Conselho de Saúde nem Fundo de Saúde, embora recebesse transferências federais. Considerando o art. 4º da Lei nº 8.142/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O não atendimento dos requisitos legais implica a suspensão definitiva dos repasses, sem possibilidade de regularização.
- (B) O não atendimento dos requisitos legais implica que os recursos sejam administrados pela União, por meio do Ministério da Saúde.
- (C) O não atendimento dos requisitos legais implica que os recursos passem a ser administrados diretamente pelo Conselho Nacional de Saúde.
- (D) O não atendimento dos requisitos legais implica que os recursos do município passem a ser administrados pelo respectivo Estado.
- (E) O não atendimento dos requisitos legais é suprido pela apresentação do plano de saúde, que dispensa o Fundo e o Conselho.

137. (SUS-028 · Financiamento) Considerando o art. 3º da Lei nº 8.142/1990, que trata do repasse dos recursos do Fundo Nacional de Saúde para a cobertura das ações e serviços de saúde, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Os recursos são repassados mediante convênio, sendo pelo menos 70% destinados aos estados e o restante aos municípios.
- (B) Os recursos são repassados de forma regular e automática, vedada a formação de consórcios municipais para sua execução.
- (C) Os recursos são repassados de forma regular e automática, sendo ao menos 50% aos municípios e o restante aos estados.
- (D) Os recursos são repassados de forma eventual, conforme a disponibilidade de caixa da União em cada exercício financeiro.
- (E) Os recursos são repassados de forma regular e automática, sendo pelo menos 70% destinados aos municípios e o restante aos estados.

138. (SUS-029 · Financiamento) Para atingir o mínimo constitucional, a prefeitura pretendia computar como gasto em saúde o pagamento de aposentadorias de ex-servidores da saúde e a pavimentação da rua de acesso a uma UBS. Considerando a LC nº 141/2012, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) Ambas as despesas podem ser computadas, desde que aprovadas pelo Conselho Municipal de Saúde no relatório anual.
- (B) Apenas a pavimentação pode ser computada, por beneficiar diretamente o acesso dos usuários à unidade de saúde.
- (C) Ambas as despesas podem ser computadas, pois se vinculam a servidores e a equipamentos que integram a rede municipal de saúde.
- (D) Nenhuma das despesas pode ser computada, pois a lei exclui expressamente aposentadorias e obras de infraestrutura.
- (E) Apenas as aposentadorias podem ser computadas, por se referirem a servidores que atuaram em ações de saúde.

139. (SUS-030 · Indicadores e monitoramento) A LC nº 141/2012 estabelece instrumentos de transparência e prestação de contas da gestão do SUS. Assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O gestor apresenta, até o fim de fevereiro, maio e setembro, relatório resumido sem detalhamento, vedada a discussão pública.

(B) O gestor apresenta, até o fim de março, maio e julho, relatório detalhado do trimestre anterior em sessão do Tribunal de Contas.

(C) O gestor apresenta, até o fim de fevereiro, maio e setembro, relatório do quadrimestre anterior em audiência na Casa Legislativa.

(D) O gestor apresenta, anualmente, relatório de gestão diretamente ao Ministério da Saúde, dispensada a audiência pública.

(E) O gestor apresenta, até o fim de cada mês, relatório detalhado do mês anterior em audiência pública perante o Conselho de Saúde.

140. (SUS-031 · Gestão municipal do SUS) A nova gestão municipal precisa elaborar seus instrumentos de planejamento em saúde para o quadriênio. Considerando a legislação do SUS sobre planejamento, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) O Plano de Saúde tem vigência quadrienal, passa pelo Conselho de Saúde e é operacionalizado pelas Programações Anuais.

(B) O Plano de Saúde tem vigência quadrienal, sendo elaborado pelo Estado e apenas executado pelo município em seu território.

(C) O Plano de Saúde tem vigência quadrienal, mas sua elaboração é facultativa para municípios com menos de 50 mil habitantes.

(D) O Plano de Saúde tem vigência anual, dispensa a apreciação do Conselho de Saúde e é operacionalizado pelo Relatório de Gestão.

(E) O Plano de Saúde tem vigência quadrienal e é aprovado pela Câmara Municipal, cabendo ao Conselho apenas tomar ciência.

141. (SUS-032 · APS e ESF) Na UBS, uma mesma equipe acompanha há anos a família de uma idosa hipertensa, conhecendo sua história e mantendo o vínculo ao longo do tempo, independentemente da presença de doença. Considerando os atributos da Atenção Primária, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A situação expressa a coordenação do cuidado, que pressupõe continuidade da relação de cuidado e vínculo ao longo do tempo.

(B) A situação expressa a integralidade, que pressupõe que a mesma equipe execute todos os procedimentos de que o usuário necessite.

(C) A situação expressa a longitudinalidade, que pressupõe continuidade da relação de cuidado e vínculo ao longo do tempo.

(D) A situação expressa o acesso de primeiro contato, que se caracteriza pela relação duradoura entre equipe e usuário.

(E) A situação expressa a longitudinalidade, que se limita ao acompanhamento durante episódios agudos de doença.

142. (SUS-033 · APS e ESF) Considerando a Política Nacional de Atenção Básica (PNAB/2017), assinale a afirmativa CORRETA quanto à população adscrita recomendada por equipe de Saúde da Família.

(A) Recomenda-se população adscrita de 2.000 a 3.500 famílias por equipe, sendo o cadastro feito por domicílio, não por pessoa.

(B) Recomenda-se população adscrita de 1.000 a 1.500 pessoas por equipe, vedada adscrição maior em áreas urbanas.

(C) Recomenda-se população adscrita de 2.000 a 3.500 pessoas por equipe, ajustável conforme vulnerabilidade e risco.

(D) Recomenda-se população adscrita de 2.000 a 3.500 pessoas por equipe, vedado qualquer ajuste por critérios de vulnerabilidade.

(E) Recomenda-se população adscrita de 4.000 a 5.000 pessoas por equipe, independentemente da vulnerabilidade do território.

143. (SUS-034 · APS e ESF) Usuária procurou diretamente o ambulatório de cardiologia de um hospital regional, sem encaminhamento, e foi orientada a buscar a UBS. Considerando o Decreto nº 7.508/2011, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) São portas de entrada às ações e serviços nas Redes de Atenção a atenção primária e os hospitais, excluída a atenção psicossocial.
- (B) São portas de entrada às ações e serviços nas Redes de Atenção todos os serviços do SUS, inclusive os ambulatórios especializados.
- (C) São portas de entrada a atenção primária, a urgência e emergência, a atenção psicossocial e os serviços especiais de acesso aberto.
- (D) São portas de entrada às ações e serviços nas Redes de Atenção os serviços definidos livremente por cada prestador contratado.
- (E) São portas de entrada às ações e serviços nas Redes de Atenção apenas os serviços de atenção primária, vedado outro acesso direto.

144. (SUS-035 · APS e ESF) O Decreto nº 7.508/2011 regulamenta a organização do SUS e estabelece requisitos mínimos para a instituição de uma Região de Saúde. Assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária, urgência e emergência e atenção hospitalar, excluída a vigilância.
- (B) A Região de Saúde deve conter, no mínimo, os serviços definidos pelo Ministério da Saúde, sem participação dos estados e municípios.
- (C) A Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de atenção primária e vigilância em saúde, sendo facultativos os demais.
- (D) A Região de Saúde deve conter, no mínimo, atenção primária, urgência, psicossocial, especializada e hospitalar, e vigilância em saúde.
- (E) A Região de Saúde deve conter, no mínimo, hospital de alta complexidade em cada município que a integra.

145. (SUS-036 · Indicadores e monitoramento) Em determinado ano, um município registrou 1.500 nascidos vivos e 12 óbitos de menores de um ano. Considerando o cálculo do coeficiente de mortalidade infantil, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O coeficiente é de 8 óbitos por mil nascidos vivos, obtido pela razão entre óbitos de menores de um ano e nascidos vivos, multiplicada por mil.
- (B) O coeficiente é de 8 óbitos por mil nascidos vivos, obtido pela razão entre óbitos de menores de cinco anos e nascidos vivos.
- (C) O coeficiente é de 125 nascidos vivos por óbito, obtido pela razão entre nascidos vivos e óbitos de menores de um ano.
- (D) O coeficiente é de 0,8 óbito por mil nascidos vivos, obtido pela razão entre óbitos de menores de um ano e nascidos vivos, vezes cem.
- (E) O coeficiente é de 8 óbitos por mil habitantes, obtido pela razão entre óbitos de menores de um ano e a população total do município.

146. (SUS-037 · Indicadores e monitoramento) Uma campanha de vacinação atingiu a meta de cobertura com custo menor que o previsto e, nos anos seguintes, reduziu as internações pela doença na população. Considerando os conceitos de avaliação em saúde, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A redução das internações expressa a eficiência, que dispensa a comparação entre os recursos empregados e os resultados obtidos.

(B) A redução das internações expressa a efetividade, que se mede apenas pelo número de doses aplicadas na campanha.

(C) A redução das internações expressa a eficiência, isto é, o impacto da intervenção nas condições de saúde da população em situação real.

(D) A redução das internações expressa a eficácia, isto é, o alcance da meta de cobertura com custo menor que o previsto.

(E) A redução das internações expressa a efetividade, isto é, o impacto real da intervenção na saúde da população.

147. (SUS-038 · Indicadores e monitoramento) Em 2025, um município com 20.000 habitantes registrou 40 casos novos de tuberculose; ao fim do ano, havia 70 pessoas em tratamento. Considerando as medidas de frequência de doenças, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A incidência no ano foi de 200 casos por 100 mil habitantes, e a prevalência tende a ser menor que a incidência em doenças crônicas.

(B) A incidência no ano foi de 2 casos por 100 mil habitantes, pois se divide o número de casos novos pela população total.

(C) A incidência no ano foi de 200 casos por 100 mil habitantes, pois considera apenas os casos novos no período.

(D) A prevalência no ano foi de 200 casos por 100 mil habitantes, pois considera apenas os casos novos no período.

(E) A incidência no ano foi de 350 casos por 100 mil habitantes, pois considera todos os casos existentes no período.

148. (SUS-039 · Controle social) O prefeito não convocou a Conferência Municipal de Saúde no prazo legal, e o Conselho Municipal de Saúde decidiu convocá-la. Considerando a Lei nº 8.142/1990, assinale a afirmativa CORRETA.

(A) A Conferência pode ser convocada pelo Poder Legislativo, a quem cabe suprir a omissão do prefeito na matéria.

(B) A Conferência pode ser convocada exclusivamente pelo Poder Executivo, sendo nula a convocação pelo Conselho.

(C) A Conferência pode ser convocada pelo Conselho apenas com autorização prévia do Ministério Público estadual.

(D) A Conferência pode ser convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por ela própria ou pelo Conselho de Saúde.

(E) A Conferência pode ser convocada pelo Conselho de Saúde, desde que a periodicidade seja reduzida para dois anos.

Gabarito comentado

- 1. A** — A tese aparece no último parágrafo ('a escrita também é parte do ato pericial') e é preparada pela ideia de que o laudo orienta decisões que mudam vidas. (*Interpretação de texto – ideia principal*) Pegadinha: Distrator que absolutiza ('eliminação de termos técnicos').
- 2. D** — 'Contudo' é conjunção coordenativa adversativa, equivalente a 'no entanto', 'todavia', 'entretanto', 'porém'. (*Coesão textual – conectivos*) Pegadinha: Troca de relação lógica entre conectivos.
- 3. C** — A metáfora opõe 'voz técnica' a 'ruído': em vez de esclarecer, o laudo obscuro acrescenta confusão. (*Interpretação – inferência e linguagem figurada*) Pegadinha: Distratores que extrapolam o texto.
- 4. B** — 'Haver' com sentido de existir ou ocorrer é impessoal e fica na 3ª pessoa do singular, contaminando o auxiliar da locução ('deve haver'). (*Gramática normativa – concordância verbal (verbos impessoais)*) Pegadinha: Concordar 'haver' com o substantivo plural.
- 5. E** — O 2º parágrafo define território vivo como produto das relações sociais, econômicas e culturais. (*Interpretação de texto – ideia principal*) Pegadinha: Inversão do ponto de vista do autor.
- 6. D** — 'Paisagem' é usada em sentido figurado (conotativo) para designar o conjunto formado por saneamento, violência, distância da escola e oferta de trabalho. (*Semântica – denotação e conotação*) Pegadinha: Tomar o sentido figurado como literal.
- 7. C** — 'Nele' (em + ele) é elemento coesivo anafórico que retoma 'o conceito de território vivo'. (*Coesão textual – referênciação*) Pegadinha: Antecedentes plausíveis, mas distantes.
- 8. A** — Conjunção coordenativa deslocada para o meio da oração ('entretanto', 'porém', 'contudo') deve ser isolada por vírgulas. (*Gramática normativa – pontuação*) Pegadinha: Confundir conjunção intercalada com aposto ou separação sujeito/verbo.
- 9. A** — 'Referir-se a' + 'a conclusão' (artigo feminino) = 'à conclusão'. Não há crase antes de verbo, de palavra masculina, de artigo indefinido e da maioria dos pronomes de tratamento. (*Gramática normativa – crase*) Pegadinha: Casos clássicos de proibição de crase.
- 10. B** — Assistir (ver) → assistir a; preferir algo a algo; obedecer a; visar (almejar) → visar a. (*Gramática normativa – regência verbal*) Pegadinha: Regências que divergem do uso coloquial.
- 11. B** — Pelo Acordo, perderam o acento os ditongos abertos 'ei' e 'oi' em paroxítonas (ideia, heroico) e os hiatos 'oo' e 'ee' (voo, creem). (*Acordo Ortográfico de 1990 (vigente desde 2016)*) Pegadinha: Grafias antigas misturadas às novas.
- 12. C** — O Manual prevê Vossa Excelência para juízes, com concordância em 3ª pessoa ('Vossa Excelência está'), e o fecho 'Respeitosamente' para autoridades de hierarquia superior; 'Atenciosamente' para mesma hierarquia ou inferior. (*Manual de Redação da Presidência da República, 3ª ed. (2018)*) Pegadinha: Troca de tratamento e de fecho.
- 13. E** — Na parassíntese, prefixo e sufixo entram simultaneamente: não existem 'entarde' nem 'tardecer'. Em 'infelizmente', existem as formas intermediárias. (*Gramática normativa – formação de palavras*) Pegadinha: Confundir parassíntese com prefixação + sufixação.
- 14. C** — Art. 37, XVI: é vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto, quando houver compatibilidade de horários, observado o teto: a) dois cargos de professor; b) um de professor com outro técnico ou científico; c) dois cargos ou empregos privativos de profissionais de saúde, com profissões regulamentadas. (*CF/88, art. 37, XVI e XVII*) Pegadinha: 'Independentemente' da compatibilidade; exigências inexistentes.
- 15. B** — Art. 37, III: o prazo de validade do concurso público será de até dois anos, prorrogável uma vez, por igual período. (*CF/88, art. 37, III*) Pegadinha: Troca de prazos e de número de prorrogações.

16. A — Art. 41: são estáveis após três anos de efetivo exercício os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso. § 4º: como condição para a aquisição da estabilidade, é obrigatória a avaliação especial de desempenho por comissão. § 1º: perda por sentença transitada em julgado, processo administrativo ou avaliação periódica de desempenho. (CF/88, art. 41, caput, §§ 1º e 4º) Pegadinha: 'Automaticamente', 'dispensada' e 'só'.

17. D — Art. 37, § 6º: as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa. (CF/88, art. 37, § 6º) Pegadinha: Inverter objetiva × subjetiva; regresso 'independentemente de culpa'.

18. E — Art. 5º, LXXII: conceder-se-á habeas data para assegurar o conhecimento de informações relativas à pessoa do impetrante, constantes de registros ou bancos de dados de entidades governamentais ou de caráter público, e para a retificação de dados. LXXVII: são gratuitas as ações de habeas corpus e habeas data. (CF/88, art. 5º, LXXII e LXXVII) Pegadinha: Troca entre remédios.

19. E — Art. 5º, LXX: o mandado de segurança coletivo pode ser impetrado por: a) partido político com representação no Congresso Nacional; b) organização sindical, entidade de classe ou associação legalmente constituída e em funcionamento há pelo menos um ano, em defesa dos interesses de seus membros ou associados. (CF/88, art. 5º, LXX) Pegadinha: Troca de prazo (1 × 2 anos) e de legitimados.

20. B — Art. 14, § 1º: o alistamento eleitoral e o voto são obrigatórios para os maiores de dezoito anos e facultativos para os analfabetos, os maiores de setenta anos e os maiores de dezesseis e menores de dezoito anos. (CF/88, art. 14, § 1º) Pegadinha: Troca 70 × 60 anos.

21. A — Art. 14, § 3º, VI: idade mínima de 35 anos (Presidente, Vice e Senador); 30 (Governador e Vice); 21 (Deputados, Prefeito, Vice-Prefeito e juiz de paz); 18 (Vereador). (CF/88, art. 14, § 3º, VI) Pegadinha: Troca entre as faixas etárias.

22. E — Erradicar a pobreza e a marginalização é OBJETIVO fundamental (art. 3º, III), não fundamento. Fundamentos (art. 1º): soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. (CF/88, arts. 1º e 3º) Pegadinha: Trocar objetivo (art. 3º) por fundamento (art. 1º).

23. A — Art. 30, VII: compete aos Municípios prestar, com a cooperação técnica e financeira da União e do Estado, serviços de atendimento à saúde da população. Art. 23, II: competência comum para cuidar da saúde. Art. 24, XII: competência concorrente (União, Estados e DF) sobre previdência social e proteção e defesa da saúde. (CF/88, arts. 22, XXIII; 23, II; 24, XII; 30, II e VII) Pegadinha: Incluir o Município na competência concorrente do art. 24.

24. C — Art. 60, § 2º: a proposta será discutida e votada em cada Casa do Congresso Nacional, em dois turnos, considerando-se aprovada se obtiver, em ambos, três quintos dos votos dos respectivos membros. § 3º: promulgada pelas Mesas. § 1º: limites circunstanciais. (CF/88, art. 60, §§ 1º a 3º) Pegadinha: Troca de quórum (3/5 × 2/3) e sanção inexistente.

25. D — Art. 60, § 4º: não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir: I – a forma federativa de Estado; II – o voto direto, secreto, universal e periódico; III – a separação dos Poderes; IV – os direitos e garantias individuais. (CF/88, art. 60, § 4º) Pegadinha: Trocar 'periódico' por 'obrigatório'; incluir forma republicana.

26. B — Art. 103: Presidente da República; Mesas do Senado, da Câmara, de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do DF; Governador; PGR; Conselho Federal da OAB; partido político com representação no Congresso; confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional. (CF/88, art. 103) Pegadinha: Incluir entes municipais e cidadão.

27. A — Eficácia plena: aplicabilidade direta, imediata e integral. Contida: aplicabilidade direta e imediata, mas possivelmente não integral, restringível por lei (ex.: art. 5º, XIII). Limitada: aplicabilidade mediata, depende de lei. (Doutrina – José Afonso da Silva) Pegadinha: Troca de conceito vizinho (contida × limitada).

28. B — Art. 144, § 8º: os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. (CF/88, art. 144, § 8º) Pegadinha: 'Obrigatoriamente' e atribuições de outras forças.

29. D — Art. 145: União, Estados, DF e Municípios poderão instituir: I – impostos; II – taxas, em razão do exercício do poder de polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis; III – contribuição de melhoria, decorrente de obras públicas. § 2º: taxas não poderão ter base de cálculo própria de impostos. (CF/88, art. 145) Pegadinha: Troca entre espécies tributárias.

30. C — Art. 62, § 1º, I, 'b': é vedada a edição de MP sobre direito penal, processual penal e processual civil. III: matéria reservada a lei complementar. § 3º: perdem eficácia se não convertidas em 60 dias, prorrogável uma vez por igual período. (CF/88, art. 62, §§ 1º a 3º) Pegadinha: Ressalvas inexistentes e troca de prazo.

31. B — O \$ antes da coluna e da linha (\$B\$1) torna a referência absoluta: ao copiar a fórmula, A2 se ajusta (A3, A4...) e \$B\$1 permanece fixo. (Microsoft Excel – referências relativas e absolutas) Pegadinha: Fixar a célula errada ou usar símbolo errado.

32. A — Sintaxe em PT-BR: =SE(teste_lógico;valor_se_verdadeiro;valor_se_falso). Textos entre aspas; >= inclui o valor limite. (Microsoft Excel – função SE) Pegadinha: Operador > × >= e ordem dos argumentos.

33. E — CONT.SE(intervalo;critério) conta as células que atendem ao critério. CONT.VALORES conta não vazias; CONT.NÚM conta números. (Microsoft Excel – funções de contagem) Pegadinha: Funções de contagem parecidas.

34. A — Word PT-BR: Ctrl+N negrito; Ctrl+I itálico; Ctrl+S sublinhado; Ctrl+B salvar; Ctrl+O novo; Ctrl+A abrir; Ctrl+P imprimir; Ctrl+T selecionar tudo; Ctrl+E centralizar; Ctrl+J justificar. (Microsoft Word – atalhos (versão em português)) Pegadinha: Confusão com os atalhos da versão em inglês (Ctrl+B = bold).

35. B — Windows+L bloqueia; Windows+E abre o Explorador; Windows+D mostra a área de trabalho; Windows+I abre Configurações; Ctrl+Shift+Esc abre o Gerenciador de Tarefas. (Microsoft Windows – atalhos de teclado) Pegadinha: Atalhos com a tecla Windows confundíveis.

36. C — Delete envia à Lixeira (em discos locais); Shift+Delete exclui permanentemente, sem passar pela Lixeira. (Microsoft Windows – gerenciamento de arquivos) Pegadinha: Confundir com recortar/ocultar.

37. B — Ransomware: sequestra dados (criptografa) e exige resgate. Worm: se propaga sozinho. Trojan: disfarça-se de programa legítimo. Keylogger: captura teclas. Backdoor: acesso remoto oculto. (Cartilha de Segurança para Internet (CERT.br)) Pegadinha: Troca entre malwares.

38. E — Phishing: tentativa de obter dados pessoais/financeiros por mensagens que se passam por instituições conhecidas, frequentemente com senso de urgência. (Cartilha de Segurança para Internet (CERT.br)) Pegadinha: Absoluto ('só ocorre por e-mail').

39. C — Completo: copia tudo. Incremental: alterados desde o último backup (completo ou incremental) — backup rápido, restauração mais trabalhosa. Diferencial: alterados desde o último completo — restauração exige o completo + o último diferencial. (Segurança da informação – políticas de backup) Pegadinha: Troca incremental × diferencial.

40. A — SMTP: envio. POP3: recebimento, geralmente baixando as mensagens para o dispositivo. IMAP: acesso às mensagens no servidor, sincronizando entre dispositivos. (Redes de computadores – protocolos de aplicação) Pegadinha: Inversão de funções entre protocolos.

41. D — CCO (Cco/Bcc): os destinatários não aparecem para os demais. CC: cópia visível. (Correio eletrônico – campos de endereçamento) Pegadinha: Troca CC × CCO.

42. D — IaaS: infraestrutura (máquinas virtuais, armazenamento). PaaS: plataforma de desenvolvimento/execução. SaaS: software pronto acessado pela internet (ex.: webmail, suítes online). (Computação em nuvem – NIST SP 800-145) Pegadinha: Troca entre IaaS, PaaS e SaaS.

43. C — Art. 5º, II, da LGPD: dado pessoal sensível inclui dado referente à saúde. Art. 11: hipóteses de tratamento de dados sensíveis, com e sem consentimento. (*Lei 13.709/2018 (LGPD), arts. 5º, II, e 11*) Pegadinha: 'Sempre do consentimento' e exclusão indevida do poder público.

44. D — Auxílio por incapacidade temporária exige, em regra, carência de 12 contribuições (art. 25, I). A preexistência só não é óbice quando a incapacidade decorre de progressão ou agravamento (art. 59, § 1º), mas isso não supre a carência. Lombalgia/hérnia não está no rol de isenção. (*Lei 8.213/1991, arts. 25, I; 26, II; 59, § 1º; 151*) Pegadinha: Misturar preexistência e carência: o agravamento resolve uma, não a outra.

45. A — Art. 26, II: independe de carência o auxílio por incapacidade temporária e a aposentadoria por incapacidade permanente ao segurado que, após filiar-se ao RGPS, for acometido de alguma das doenças do art. 151 (entre elas, neoplasia maligna). (*Lei 8.213/1991, arts. 26, II, e 151*) Pegadinha: Isenção de carência ≠ dispensa de incapacidade; exige acometimento após a filiação.

46. B — O auxílio-acidente é devido, como indenização, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza que resultem em sequela redutora da capacidade (art. 86), independe de carência (art. 26, I) e só é concedido a empregado, empregado doméstico, trabalhador avulso e segurado especial (art. 18, § 1º). (*Lei 8.213/1991, arts. 18, § 1º; 26, I; 86*) Pegadinha: Atribuir o óbice ao motivo errado (natureza do acidente ou carência).

47. A — Art. 86: auxílio-acidente concedido como indenização quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho habitual. § 1º: 50% do salário de benefício. (*Lei 8.213/1991, art. 86*) Pegadinha: Confundir com benefício por incapacidade (substitutivo de renda).

48. B — Art. 45: o valor da aposentadoria por incapacidade permanente do segurado que necessitar da assistência permanente de outra pessoa será acrescido de 25%. Parágrafo único: devido ainda que o valor atinja o limite máximo legal; recalculado com o benefício; cessa com a morte, não se incorporando à pensão. (*Lei 8.213/1991, art. 45; Decreto 3.048/1999, Anexo I*) Pegadinha: 'Limitado ao teto' e 'incorpora à pensão'.

49. D — Art. 101: o segurado em gozo de benefício por incapacidade está obrigado a submeter-se a exame médico, a processo de reabilitação profissional e a tratamento gratuito, exceto o cirúrgico e a transfusão de sangue, que são facultativos. (*Lei 8.213/1991, art. 101*) Pegadinha: Generalizar a obrigação de tratamento.

50. E — Art. 60, § 8º: sempre que possível, o ato de concessão ou reativação judicial ou administrativa deverá fixar o prazo estimado para a duração do benefício. § 9º: na ausência de fixação, o benefício cessará após 120 dias, exceto se o segurado requerer a prorrogação. (*Lei 8.213/1991, art. 60, §§ 8º e 9º*) Pegadinha: Troca do prazo supletivo e vedação inexistente de prorrogação.

51. C — A incapacidade é avaliada em relação à atividade habitual (art. 59). Com prognóstico definido de recuperação, a incapacidade é temporária; a reabilitação (art. 62) é indicada quando o segurado é insuscetível de recuperação para a atividade habitual. (*Lei 8.213/1991, arts. 59, 62 e 86*) Pegadinha: Antecipar consolidação ou reabilitação; confundir atividade habitual com qualquer atividade.

52. E — Art. 62: o segurado em gozo de auxílio por incapacidade temporária, insuscetível de recuperação para sua atividade habitual, deverá submeter-se a processo de reabilitação profissional para outra atividade. A aposentadoria (art. 42) pressupõe impossibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência. (*Lei 8.213/1991, arts. 42 e 62*) Pegadinha: Saltar da incapacidade para a atividade habitual direto para a aposentadoria.

53. A — Art. 20, § 1º: não são consideradas doença do trabalho a degenerativa, a inerente a grupo etário, a que não produza incapacidade laborativa e a endêmica (salvo exposição pela natureza do trabalho). O art. 21, I, equipara a acidente o agravo para o qual o trabalho contribuiu diretamente, ainda que não seja causa única (concausa). (*Lei 8.213/1991, arts. 20, § 1º, e 21, I*) Pegadinha: Absolutos opostos: 'sempre' × 'nunca'.

54. C — Art. 20, § 1º, 'd': não é considerada doença do trabalho a doença endêmica adquirida por segurado habitante de região em que ela se desenvolva, salvo comprovação de que resultou de exposição ou contato direto determinado pela natureza do trabalho. (*Lei 8.213/1991, art. 20, § 1º, 'd'*) Pegadinha: Regra geral

apresentada sem a exceção legal.

55. A — Art. 21-A: a perícia médica do INSS considerará caracterizada a natureza acidentária quando constatar nexo técnico epidemiológico entre o trabalho e o agravo, decorrente da relação entre a atividade da empresa e a entidade mórbida (CID). § 1º: deixa de aplicar quando demonstrada a inexistência. § 2º: a empresa pode requerer a não aplicação, com efeito suspensivo, cabendo recurso ao CRPS. (*Lei 8.213/1991, art. 21-A; Decreto 3.048/1999, art. 337 e Anexo II, Lista C*) Pegadinha: Absoluta × relativa; vincular NTEP à CAT.

56. D — Art. 22: a empresa comunicará o acidente à Previdência até o 1º dia útil seguinte ao da ocorrência e, em caso de morte, de imediato. § 2º: na falta, podem formalizá-la o acidentado, seus dependentes, a entidade sindical, o médico que o assistiu ou qualquer autoridade pública, não prevalecendo o prazo. (*Lei 8.213/1991, art. 22*) Pegadinha: Troca de prazos e de legitimados.

57. B — Critérios clássicos (Simonin / Muller-Cordonnier): natureza adequada do traumatismo e da lesão, adequação entre sede do trauma e da lesão, encadeamento anatomoclínico, adequação temporal, exclusão de causa estranha e consideração do estado anterior. (*Medicina Legal – avaliação do dano corporal (critérios de nexo de causalidade)*) Pegadinha: 'Por si só' e 'apenas' em critérios cumulativos.

58. E — Concausa é fator que, somado à causa principal, concorre para o resultado; classifica-se em preexistente, concomitante ou superveniente. Na Lei 8.213 (art. 21, I), o trabalho que contribuiu diretamente, sem ser causa única, caracteriza acidente. (*Medicina Legal; Lei 8.213/1991, art. 21, I*) Pegadinha: 'Sempre' e 'restringem-se'.

59. C — Art. 20, § 2º: pessoa com deficiência é aquela com impedimento de longo prazo de natureza física, mental, intelectual ou sensorial que, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade. § 10: longo prazo = mínimo de 2 anos. § 6º: avaliação médica e social. (*Lei 8.742/1993, art. 20, §§ 2º, 6º e 10*) Pegadinha: Confundir incapacidade laboral (RGPS) com deficiência (BPC).

60. E — Art. 20: o BPC é a garantia de um salário mínimo mensal à pessoa com deficiência e ao idoso com 65 anos ou mais que comprovem não possuir meios de prover a própria manutenção nem de tê-la provida por sua família. (*Lei 8.742/1993, art. 20*) Pegadinha: Troca de idade (60 × 65) e exigência de contribuição.

61. E — Art. 93: é vedado ao médico ser perito ou auditor do próprio paciente, de pessoa de sua família ou de qualquer outra com a qual tenha relações capazes de influir em seu trabalho ou de empresa em que atue ou tenha atuado. (*Res. CFM 2.217/2018 (CEM), art. 93*) Pegadinha: Condicionantes falsas ('desde que concorde', 'apenas na judicial').

62. C — Art. 92: é vedado ao médico assinar laudos periciais, auditoriais ou de verificação médico-legal caso não tenha realizado pessoalmente o exame. (*Res. CFM 2.217/2018 (CEM), art. 92*) Pegadinha: 'Desde que' legitimando conduta vedada.

63. D — Art. 97: é vedado ao médico autorizar, vetar, bem como modificar, quando na função de auditor ou de perito, procedimentos propedêuticos ou terapêuticos instituídos, salvo, no último caso, em situações de urgência, emergência ou iminente perigo de morte do paciente, comunicando, por escrito, o fato ao médico assistente. (*Res. CFM 2.217/2018 (CEM), art. 97*) Pegadinha: Absoluto ('sempre vedado') e supressão do dever de comunicar.

64. D — Art. 94: é vedado ao médico intervir, quando em função de auditor, assistente técnico ou perito, nos atos profissionais de outro médico, ou fazer qualquer apreciação em presença do examinado, reservando suas observações para o relatório. (*Res. CFM 2.217/2018 (CEM), arts. 92, 94, 96 e 98*) Pegadinha: Comando INCORRETA: as demais são literalidade do CEM.

65. D — Art. 466, § 1º: os assistentes técnicos são de confiança da parte e não estão sujeitos a impedimento ou suspeição. § 2º: o perito deve assegurar aos assistentes o acesso e o acompanhamento das diligências, com prévia comunicação, comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 dias. (*CPC, art. 466, §§ 1º e 2º*) Pegadinha: Estender ao assistente regras do perito.

66. D — Art. 473, § 2º: é vedado ao perito ultrapassar os limites de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico ou científico do objeto da perícia. Inciso IV: resposta conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo MP. (CPC, art. 473, IV e § 2º) Pegadinha: Confundir conclusão técnica com conclusão jurídica.

67. E — Art. 479: o juiz apreciará a prova pericial de acordo com o art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo. Art. 480: nova perícia quando a matéria não estiver suficientemente esclarecida. (CPC, arts. 371, 479 e 480) Pegadinha: Vinculação × livre convencimento sem motivação.

68. D — Art. 157, § 1º: a escusa será apresentada no prazo de 15 dias, contado da intimação, da suspeição ou do impedimento supervenientes, sob pena de renúncia ao direito a alegá-la. Art. 148, II, e art. 145, I: amizade íntima é causa de suspeição aplicável ao perito. (CPC, arts. 145, 148, II, e 157, § 1º) Pegadinha: Troca de prazo e de termo inicial.

69. B — Os sinais de Waddell (sensibilidade, simulação, distração, distúrbios regionais e reação exagerada) indicam componente não orgânico quando positivos em três ou mais das cinco categorias; não diferenciam simulação de fatores psicossociais. (Waddell et al., Spine 1980 – semiologia pericial) Pegadinha: Equiparar 'não orgânico' a 'simulação'.

70. C — No teste de Hoover, a flexão do quadril contralateral contra resistência provoca extensão involuntária do quadril 'parético'. Força presente nessa manobra, ausente no teste direto, sugere fraqueza funcional. (Semiologia neurológica aplicada à perícia) Pegadinha: Troca de epônimos e de interpretação (positivo × negativo).

71. A — Na perícia, a incapacidade é inferida da repercussão funcional (sintomas, exame psíquico, gravidade, adesão e tempo de tratamento) frente às exigências da atividade; o diagnóstico isolado não define incapacidade nem sua duração. (Diretrizes de perícia médica (INSS) – transtornos mentais) Pegadinha: 'Por si só' e 'vincula'.

72. B — Na CID-11 (vigente na OMS desde 01/01/2022), 'burn-out' (QD85) integra o capítulo 'Fatores que influenciam o estado de saúde ou o contato com serviços de saúde', definido como fenômeno ocupacional resultante de estresse crônico no trabalho não gerenciado com sucesso. (OMS – CID-11, QD85) Pegadinha: Classificar como transtorno mental ou ampliar para contextos não ocupacionais.

73. A — Parestesias no território do mediano, Phalen e Tinel no punho e hipotrofia tenar sugerem STC; a eletroneuromiografia confirma e gradua o comprometimento. (Semiologia ortopédica/neurológica; DORT) Pegadinha: Troca de território nervoso e de estadiamento.

74. C — PAIR: perda neurossensorial, quase sempre bilateral e simétrica, irreversível, com entalhe em 3, 4 ou 6 kHz e recuperação em 8 kHz; não progride após cessada a exposição; raramente ultrapassa 40 dB nas frequências baixas e 75 dB nas altas. (Ministério da Saúde – Perda Auditiva Induzida por Ruído (Protocolo); NR-7) Pegadinha: Troca condutiva × neurossensorial; progressão sem exposição.

75. D — CVF reduzida com VEF1/CVF normal ou elevada sugere distúrbio ventilatório restritivo, que deve ser confirmado pela redução da capacidade pulmonar total (pletismografia ou diluição de gases). Contexto compatível com silicose. (Diretrizes SBPT para testes de função pulmonar) Pegadinha: Interpretar relação elevada como obstrução; 'dispensável'.

76. D — Cardiopatia grave é conceito médico-pericial baseado em limitação funcional (ex.: NYHA III–IV), disfunção ventricular (ex.: FE reduzida), isquemia, arritmias graves e prognóstico — não no rótulo diagnóstico. (Lei 8.213/1991, art. 151; consenso de cardiopatia grave (SBC) – critérios funcionais) Pegadinha: Diagnóstico ou atestado tratados como suficientes.

77. D — Súmula 78 da TNU: comprovado que o requerente é portador do HIV, cabe ao julgador verificar as condições pessoais, sociais, econômicas e culturais, de forma a analisar a incapacidade em sentido amplo, em face da elevada estigmatização social da doença. (TNU, Súmula 78) Pegadinha: Restringir a análise ao quadro clínico; mito de transmissão alimentar.

78. A — Em 1.000 pessoas: 100 doentes → 90 VP; 900 sadios → 180 FP (20%). $VPP = 90 \div (90 + 180) \approx 33\%$. O VPP cai quando a prevalência cai. (*Epidemiologia clínica – testes diagnósticos*) Pegadinha: Confundir sensibilidade/especificidade com valores preditivos.

79. B — Caso-controle seleciona por desfecho; estima-se a OR. Em doenças raras a OR aproxima-se do RR. Coortes permitem incidência e RR. (*Epidemiologia clínica – desenhos de estudo*) Pegadinha: 'Sempre equivale' e troca de medidas.

80. A — Para terapêutica, o maior nível de evidência é a revisão sistemática (com ou sem metanálise) de ECR homogêneos e de boa qualidade. (*Oxford CEBM – níveis de evidência*) Pegadinha: Confundir tamanho amostral ou experiência com nível de evidência.

81. C — Na dermatite de contato alérgica ocupacional, o teste de contato identifica o alérgeno; a melhora com o afastamento e a piora no retorno reforçam onexo. (*Dermatoses ocupacionais – Ministério da Saúde*) Pegadinha: Troca irritativa × alérgica.

82. C — Após AVC, a recuperação é mais acentuada nos primeiros 3 a 6 meses; em fase de reabilitação ativa, a conclusão adequada costuma ser incapacidade temporária com reavaliação, considerando a função exercida. (*Neurologia – prognóstico funcional pós-AVC*) Pegadinha: Conclusões definitivas precoces.

83. E — Na perícia, o que define incapacidade é o risco e a repercussão funcional (hipoglicemias graves recorrentes) frente às exigências da atividade, sobretudo atividades de risco a si e a terceiros. (*Perícia médica – endocrinopatias e atividades de risco*) Pegadinha: Diagnóstico como critério isolado.

84. B — CID-10: cap. V – F (transtornos mentais); VI – G (sistema nervoso); IX – I (circulatório); X – J (respiratório); XIII – M (osteomuscular); XIX – S/T (lesões). (*OMS – CID-10*) Pegadinha: Letras vizinhas e confundíveis (F/G, M/S, I/C, J/R).

85. C — NR 7: o exame demissional deve ser feito em até 10 dias do término do contrato e pode ser dispensado se o exame clínico ocupacional mais recente tiver menos de 135 dias (graus de risco 1 e 2) ou menos de 90 dias (graus 3 e 4). Questão inspirada na FGV/Macaé 2024 (gabarito: dispensa só para Dionísio). (*NR 7 (exame clínico demissional)*) Pegadinha: Inverter os prazos: o grau de risco MAIOR tem o prazo MENOR (90 dias).

86. B — NR 7: o exame de retorno deve ser realizado antes que o empregado reassuma as funções quando ausente por 30 dias ou mais por doença ou acidente, de natureza ocupacional ou não. Na avaliação, o médico define a necessidade de retorno gradativo (gabarito Cebraspe/MPS 2025, item 80: Certo). (*NR 7 (exame de retorno ao trabalho)*) Pegadinha: Achar que o retorno só vale para doença ocupacional.

87. E — NR 7, Anexo II: a audiometria deve ser feita, no mínimo, na admissão, anualmente e na demissão (gabarito FGV/Macaé 2024, questão 55). (*NR 7, Anexo II (Controle médico ocupacional da exposição a níveis de pressão sonora elevados)*) Pegadinha: Confundir a audiometria anual com a periodicidade bienal do exame clínico dos demais empregados.

88. A — O ASO informa aptidão ou inaptidão, riscos, exames e médico responsável. O diagnóstico é protegido pelo sigilo médico e não vai ao empregador (CEM, art. 76). (*NR 7 (conteúdo do ASO)*; CEM, art. 76) Pegadinha: Confundir aptidão (que vai ao empregador) com diagnóstico (que é sigiloso).

89. E — NR 15: radiações ionizantes (Anexo 5) geram insalubridade de grau máximo (adicional de 40% sobre o salário mínimo); calor (Anexo 3), grau médio (20%). Gabaritos UFG/Goiania 2022, questões 36 e 37. (*NR 15, Anexos 3 e 5; item 15.2*) Pegadinha: Os percentuais: máximo 40%, médio 20%, mínimo 10%.

90. A — Quantitativos: ruído, calor, radiações ionizantes, vibração, poeiras minerais e os agentes químicos do Anexo 11. Qualitativos: radiações não ionizantes, frio, umidade, agentes químicos do Anexo 13 e biológicos (Anexo 14). Gabaritos UFG/Goiania 2022, questões 38 e 39. (*NR 15, Anexos 1 a 14*) Pegadinha: Frio e umidade parecem mensuráveis, mas são avaliados por inspeção.

91. D — NR 15, Anexo 1: 85 dB(A) → 8 h; cada aumento de 5 dB reduz pela metade o tempo (90 → 4 h; 95 → 2 h; 100 → 1 h). Não é permitida exposição acima de 115 dB(A) sem proteção adequada. Gabarito UFG/Goiânia 2022, questão 49. (NR 15, Anexo 1) Pegadinha: Errar a regra de dobra: cada +5 dB(A) corta o tempo pela metade.

92. E — NR 15, item 15.3: havendo mais de um fator de insalubridade, considera-se apenas o de grau mais elevado para o adicional, vedada a percepção cumulativa. O adicional cessa com a eliminação ou neutralização do risco (item 15.4). (NR 15, itens 15.2 a 15.4) Pegadinha: Somar adicionais de agentes diferentes.

93. A — NR 1: o PGR deve conter, no mínimo, inventário de riscos e plano de ação. O PCMSO (NR 7) deve estar articulado com os riscos do PGR. (NR 1, item 1.5.7.1) Pegadinha: Confundir os documentos do PGR (NR 1) com os do PCMSO (NR 7).

94. C — A NR 32 veda o reencape e a desconexão manual de agulhas em qualquer situação; luva não autoriza o reencape. (NR 32 (agentes biológicos: vedações, perfurocortantes e vacinação)) Pegadinha: Achar que o EPI torna aceitável uma prática que a norma veda.

95. B — NR 17, anexo de teleatendimento: máximo de 6 horas diárias de efetiva atividade, incluídas as pausas; duas pausas de 10 minutos contínuos e intervalo de 20 minutos para repouso e alimentação. Gabarito UFG/Goiânia 2022, questão 48. (NR 17, Anexo II) Pegadinha: Aplicar a jornada geral de 8 horas a uma atividade com limite especial.

96. E — Schilling: I – trabalho como causa necessária (doenças profissionais clássicas: silicose, saturnismo); II – fator contributivo, não necessário (coronariopatia, varizes, cânceres); III – provocador de distúrbio latente ou agravador de doença estabelecida (asma, dermatite de contato alérgica, transtornos mentais). (Ministério da Saúde, Doenças relacionadas ao trabalho: manual de procedimentos (2001)) Pegadinha: Pôr no grupo III doenças que só existem com a exposição ocupacional.

97. B — Pneumoconiose = doença pulmonar por deposição de poeira com reação tecidual. A radiografia de tórax padronizada pela OIT é a referência para rastreio e vigilância; a espirometria avalia o prejuízo funcional. A Cebraspe (MPS 2025, item 68) considerou ERRADO chamar a asma ocupacional de pneumoconiose. (Classificação Internacional de Radiografias de Pneumoconioses (OIT); NR 7, Anexo III) Pegadinha: Pôr a asma ocupacional entre as pneumoconioses.

98. D — CID-10 F43.1: o TEPT surge como resposta tardia ou protraída a evento traumático, com latência que pode ir de semanas a meses (raramente mais de 6 meses). Cursa com reviviscências, evitação, embotamento e hiperexcitação. (CID-10 F43.1 (OMS)) Pegadinha: Exigir início imediato; o 'pós' indica resposta tardia.

99. E — Art. 15: até 12 meses após cessarem as contribuições (II), prorrogáveis para 24 meses se já pagou mais de 120 contribuições sem perder a qualidade (§ 1º) e acrescidos de 12 meses para o desempregado que comprovar a situação (§ 2º). O facultativo tem 6 meses (VI). (Lei 8.213/1991, art. 15) Pegadinha: Contar anos como se fossem mais de 120 contribuições.

100. E — O BPC/LOAS é benefício assistencial, não previdenciário: não mantém a qualidade de segurado. Sem limite de prazo, só quem está em gozo de benefício previdenciário, exceto o auxílio-acidente (art. 15, I). Cebraspe (MPS 2025, item 93) julgou ERRADO incluir o BPC. (Lei 8.213/1991, art. 15; Lei 8.742/1993, art. 20) Pegadinha: Tratar o BPC (assistência) como benefício previdenciário.

101. A — Art. 27-A: perda a qualidade de segurado, para auxílio por incapacidade temporária, aposentadoria por incapacidade permanente, salário-maternidade e auxílio-reclusão o segurado deve contar, a partir da nova filiação, com metade da carência. Para o auxílio (carência de 12), são 6. Gabarito Cebraspe MPS 2025, item 95: Certo. (Lei 8.213/1991, arts. 25, I, e 27-A) Pegadinha: Lembrar a regra antiga de um terço.

102. B — Art. 118: o segurado que sofreu acidente do trabalho tem garantida, pelo prazo mínimo de 12 meses, a manutenção do contrato após a cessação do auxílio-doença acidentário, independentemente de percepção de auxílio-acidente. (Lei 8.213/1991, art. 118) Pegadinha: Trocar 'mínimo' por 'máximo'.

103. A — Art. 86, § 4º: a perda da audição, em qualquer grau, só gera auxílio-acidente quando, além do nexo com o trabalho, resultar comprovadamente em redução ou perda da capacidade para o trabalho habitual. Gabarito Cebraspe MPS 2025, item 100: Certo. (*Lei 8.213/1991, art. 86, § 4º*) Pegadinha: Achar que nexo reconhecido basta.

104. C — LOAS, art. 21: o BPC deve ser revisto a cada 2 anos. Art. 20, § 4º: não pode ser acumulado com outro benefício da seguridade social, salvo assistência médica e pensão especial indenizatória. Deficiência = impedimento de longo prazo, mínimo de 2 anos (art. 20, §§ 2º e 10). (*Lei 8.742/1993, arts. 20 e 21*) Pegadinha: Aplicar regras previdenciárias (carência, pensão) a benefício assistencial.

105. C — Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV: isentos os proventos de aposentadoria ou reforma (e pensão) recebidos por portadores das doenças listadas (moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, Paget avançado, contaminação por radiação, AIDS, fibrose cística). O rol é taxativo. (*Lei 7.713/1988, art. 6º, XIV*) Pegadinha: Achar que a isenção vale para o salário da ativa.

106. C — CEM, art. 76: é vedado revelar informações confidenciais obtidas em exames médicos de trabalhadores, inclusive por exigência dos dirigentes de empresas, salvo se o silêncio puser em risco a saúde dos empregados ou da comunidade. Art. 73: sigilo, salvo motivo justo, dever legal ou consentimento por escrito do paciente. (*Resolução CFM 2.217/2018 (CEM), arts. 73 e 76*) Pegadinha: Achar que o vínculo com a empresa autoriza a revelação.

107. B — CEM, art. 96: é vedado receber remuneração ou gratificação por valores vinculados à glosa ou ao sucesso da causa quando na função de perito ou auditor. (*Resolução CFM 2.217/2018 (CEM), arts. 92, 93, 96, 97 e 98*) Pegadinha: Honorário de êxito compromete a isenção do perito.

108. A — CPC, art. 473: exposição do objeto, análise técnica, método e respostas conclusivas aos quesitos. O § 2º veda ao perito ultrapassar os limites de sua designação e emitir opiniões pessoais que excedam o exame técnico. (*CPC (Lei 13.105/2015), art. 473*) Pegadinha: O perito responde ao técnico; quem decide o jurídico é o juiz.

109. B — Incapacidade é conclusão funcional: correlaciona história, exame, classe funcional (NYHA) e exigências da atividade habitual. O atestado do assistente não vincula. O perito não prescreve nem altera tratamento. Caso inspirado no Cebraspe MPS 2025 (itens 52–53). (*Manual Técnico de Perícia Médica Previdenciária (INSS); CEM, art. 97*) Pegadinha: Concluir só pelo diagnóstico ou só pelo exame em repouso.

110. A — Literalidade do art. 196: direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. (*CF/88, art. 196*) Pegadinha: Distratores com 'prioritariamente', 'exclusivamente' e 'restringe-se' que reduzem o alcance do direito.

111. B — O art. 197 declara as ações e serviços de saúde de relevância pública e admite execução direta ou por terceiros, mantendo com o Poder Público a regulamentação, a fiscalização e o controle. (*CF/88, art. 197*) Pegadinha: Confundir 'relevância pública' com 'execução exclusivamente pública'.

112. B — Diretrizes do art. 198: I – descentralização, com direção única em cada esfera de governo; II – atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, sem prejuízo dos serviços assistenciais; III – participação da comunidade. (*CF/88, art. 198, I a III*) Pegadinha: Inversão de prioridade (preventivo × assistencial) e troca de 'direção única' por 'compartilhada'.

113. D — Pela LC 141/2012 (art. 7º), os Municípios aplicam anualmente, no mínimo, 15% da arrecadação dos impostos do art. 156 e dos recursos dos arts. 158 e 159, I, 'b' e § 3º, da CF. Estados: 12%. (*CF/88, art. 198, §§ 2º e 3º; LC 141/2012, arts. 6º e 7º*) Pegadinha: Trocar o percentual do município (15%) pelo do Estado (12%) ou pelo da educação (25%).

114. B — Art. 199: assistência livre à iniciativa privada; participação complementar mediante contrato de direito público ou convênio, com preferência para filantrópicas e sem fins lucrativos (§ 1º); vedada subvenção a

instituições com fins lucrativos (§ 2º). (CF/88, art. 199, §§ 1º a 3º) Pegadinha: Condicionante falsa ('desde que aprovada pelo Conselho') legitimando uma vedação absoluta.

115. E — Quanto ao saneamento, o SUS 'participa da formulação da política e da execução das ações' (art. 200, IV) — não tem exclusividade. (CF/88, art. 200, II, III, IV, VI e VIII) Pegadinha: Troca de 'participar' por 'formular com exclusividade'.

116. E — Art. 3º: os níveis de saúde expressam a organização social e econômica do País, tendo como determinantes e condicionantes, entre outros, alimentação, moradia, saneamento básico, meio ambiente, trabalho, renda, educação, atividade física, transporte, lazer e acesso aos bens e serviços essenciais. (Lei 8.080/1990, arts. 2º, § 2º, e 3º) Pegadinha: Absolutos: 'exclusivamente', 'apenas', 'dispensa'.

117. E — Art. 4º: o SUS é o conjunto de ações e serviços de saúde prestados por órgãos e instituições públicas federais, estaduais e municipais, da administração direta e indireta e das fundações mantidas pelo Poder Público. § 2º: a iniciativa privada poderá participar em caráter complementar. (Lei 8.080/1990, art. 4º, caput e § 2º) Pegadinha: 'Complementar' trocado por 'obrigatório' ou 'substitutivo'.

118. D — § 1º do art. 6º: vigilância sanitária é o conjunto de ações capaz de eliminar, diminuir ou prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente, da produção e circulação de bens e da prestação de serviços de interesse da saúde. (Lei 8.080/1990, art. 6º, § 1º) Pegadinha: Confusão entre vigilância sanitária e epidemiológica.

119. C — § 2º do art. 6º: vigilância epidemiológica é o conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos. (Lei 8.080/1990, art. 6º, § 2º; art. 18, IV) Pegadinha: 'Limita-se' e 'exclusivamente' + inversão de competência.

120. C — Art. 7º, II: integralidade de assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo das ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso em todos os níveis de complexidade do sistema. (Lei 8.080/1990, art. 7º, II) Pegadinha: Troca de conceito vizinho: integralidade × igualdade × universalidade.

121. C — Art. 7º, IX: descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo: a) ênfase na descentralização dos serviços para os municípios; b) regionalização e hierarquização da rede de serviços de saúde. (Lei 8.080/1990, art. 7º, IX) Pegadinha: Trocar município por estado; 'dispensando' a regionalização.

122. B — Art. 7º, VII: utilização da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática. (Lei 8.080/1990, art. 7º, VII) Pegadinha: 'Restringe-se' tira parte do conteúdo do princípio.

123. A — Art. 9º: a direção do SUS é exercida, no âmbito da União, pelo Ministério da Saúde; nos Estados e DF, pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente; nos Municípios, pela Secretaria de Saúde ou órgão equivalente. (Lei 8.080/1990, art. 9º, III) Pegadinha: Confundir instância de controle social (Conselho) ou de pactuação (CIB) com direção.

124. B — Art. 18, IV: compete à direção municipal executar serviços de vigilância epidemiológica, vigilância sanitária, alimentação e nutrição, saneamento básico e saúde do trabalhador. (Lei 8.080/1990, arts. 16, 17 e 18, IV) Pegadinha: Inversão de competência entre União, Estado e Município.

125. A — Art. 18, X: celebrar contratos e convênios com entidades prestadoras de serviços privados de saúde, bem como controlar e avaliar sua execução; XI: controlar e fiscalizar os procedimentos dos serviços privados de saúde. (Lei 8.080/1990, art. 18, X e XI) Pegadinha: Atribuir parte da competência (o controle) a outro ator.

126. E — Art. 17, III: prestar apoio técnico e financeiro aos Municípios e executar supletivamente ações e serviços de saúde. O inciso I prevê promover a descentralização para os Municípios. (Lei 8.080/1990, art. 17, I e III) Pegadinha: 'Vedado' e 'em caráter exclusivo' em competências compartilhadas.

127. A — Art. 14-A: as Comissões Intergestores Bipartite e Tripartite são reconhecidas como foros de negociação e pactuação entre gestores, quanto aos aspectos operacionais do SUS. (*Lei 8.080/1990, art. 14-A*) Pegadinha: Confundir pactuação entre gestores com controle social.

128. B — Art. 24: quando as disponibilidades forem insuficientes, o SUS poderá recorrer aos serviços da iniciativa privada. Art. 25: preferência às filantrópicas e sem fins lucrativos. Art. 26: critérios e valores de remuneração estabelecidos pela direção nacional e aprovados no CNS. (*Lei 8.080/1990, arts. 24, 25 e 26*) Pegadinha: Condições falsas ('independentemente', 'livremente', 'dispensando').

129. D — Art. 33: os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de sua atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos Conselhos de Saúde. (*Lei 8.080/1990, art. 33*) Pegadinha: Trocar o fiscal (Conselho) por outro órgão ou dar ao Conselho papel executivo.

130. B — Art. 36: o processo de planejamento e orçamento do SUS será ascendente, do nível local até o federal, ouvidos seus órgãos deliberativos, compatibilizando-se as necessidades da política de saúde com a disponibilidade de recursos em planos de saúde dos Municípios, Estados, DF e União. (*Lei 8.080/1990, art. 36*) Pegadinha: Ascendente × descendente; 'dispensada a oitiva'.

131. A — Art. 19-J: os serviços de saúde do SUS, da rede própria ou conveniada, ficam obrigados a permitir a presença, junto à parturiente, de 1 acompanhante durante todo o período de trabalho de parto, parto e pós-parto imediato, indicado pela parturiente. (*Lei 8.080/1990, art. 19-J (Lei 11.108/2005)*) Pegadinha: Restrição temporal ('apenas', 'somente') e de quem indica.

132. E — Art. 19-Q: a incorporação, exclusão ou alteração de medicamentos, produtos e procedimentos são atribuições do Ministério da Saúde, assessorado pela CONITEC. Art. 19-R: processo concluído em até 180 dias, prorrogáveis por 90 dias. (*Lei 8.080/1990, arts. 19-Q, 19-R e 19-T (Lei 12.401/2011)*) Pegadinha: Troca de órgão (MS × ANVISA) e troca de prazo.

133. A — Art. 1º, § 1º: a Conferência de Saúde reunir-se-á a cada quatro anos com a representação dos vários segmentos sociais, para avaliar a situação de saúde e propor as diretrizes para a formulação da política de saúde, convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. (*Lei 8.142/1990, art. 1º, § 1º*) Pegadinha: Troca de prazo (4 × 2 anos) e troca de características Conferência × Conselho.

134. B — Art. 1º, § 2º: o Conselho de Saúde, em caráter permanente e deliberativo, atua na formulação de estratégias e no controle da execução da política de saúde, inclusive nos aspectos econômicos e financeiros, cujas decisões serão homologadas pelo chefe do poder legalmente constituído em cada esfera do governo. (*Lei 8.142/1990, art. 1º, § 2º*) Pegadinha: Consultivo × deliberativo; 'dispensada a homologação'.

135. D — Art. 1º, § 4º: a representação dos usuários será paritária em relação ao conjunto dos demais segmentos. A Resolução CNS 453/2012 orienta: 50% usuários, 25% trabalhadores da saúde e 25% gestores/prestadores. (*Lei 8.142/1990, art. 1º, § 4º; Res. CNS 453/2012*) Pegadinha: Ler 'paridade' como divisão igual por terços.

136. D — Art. 4º: para receber recursos, Municípios, Estados e DF devem contar com Fundo de Saúde, Conselho de Saúde paritário, plano de saúde, relatórios de gestão, contrapartida no orçamento e comissão de PCCS. Parágrafo único: o não atendimento implica a administração dos recursos pelos Estados ou pela União, respectivamente. (*Lei 8.142/1990, art. 4º e parágrafo único*) Pegadinha: Trocar quem administra (Estado × União) e 'definitiva'.

137. E — Art. 3º: os recursos serão repassados de forma regular e automática para Municípios, Estados e DF. § 2º: os recursos serão destinados, pelo menos 70%, aos Municípios, afetando-se o restante aos Estados. § 3º: municípios podem estabelecer consórcio. (*Lei 8.142/1990, art. 3º, §§ 2º e 3º*) Pegadinha: Inverter destinatário do percentual e trocar 70% por 50%.

138. D — Art. 4º da LC 141/2012: não constituem despesas com ações e serviços públicos de saúde, entre outras, o pagamento de aposentadorias e pensões, inclusive dos servidores da saúde (I), e obras de infraestrutura, ainda que realizadas para beneficiar direta ou indiretamente a rede de saúde (IX). (*LC 141/2012*,

art. 4º, I e IX) Pegadinha: Justificativa 'beneficia a saúde' para despesa excluída; condicionante falsa 'desde que aprovadas'.

139. C — Art. 36, § 5º, da LC 141/2012: o gestor do SUS apresentará, até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, em audiência pública na Casa Legislativa do respectivo ente, o Relatório detalhado do quadrimestre anterior (RDQA). (LC 141/2012, art. 36, § 5º) Pegadinha: Troca de periodicidade (mês/trimestre) e de local (Conselho/TCE).

140. A — O Plano de Saúde, base das atividades e programações de cada nível, tem vigência de quatro anos, é submetido ao Conselho de Saúde e operacionalizado anualmente pela Programação Anual de Saúde; o Relatório Anual de Gestão apresenta os resultados. (Lei 8.080/1990, art. 36; Lei 8.142/1990, art. 4º, III; LC 141/2012, art. 36; Portaria de Consolidação GM/MS 1/2017) Pegadinha: Trocar o papel de cada instrumento (Plano × PAS × RAG).

141. C — Longitudinalidade: continuidade da relação de cuidado, com construção de vínculo e responsabilização entre profissionais e usuários ao longo do tempo e de modo permanente. (PNAB – Portaria de Consolidação GM/MS 2/2017, Anexo XXII (Portaria 2.436/2017)) Pegadinha: Troca entre atributos vizinhos (longitudinalidade × coordenação × primeiro contato).

142. C — A PNAB/2017 recomenda população adscrita por equipe de Atenção Básica e de Saúde da Família de 2.000 a 3.500 pessoas, podendo haver parâmetros diferentes conforme especificidades, vulnerabilidade e riscos do território. (PNAB – Portaria de Consolidação GM/MS 2/2017, Anexo XXII) Pegadinha: Trocar 'pessoas' por 'famílias' e absolutos ('vedado').

143. C — Art. 9º do Decreto 7.508/2011: são Portas de Entrada às ações e serviços de saúde nas Redes de Atenção à Saúde: I – de atenção primária; II – de atenção de urgência e emergência; III – de atenção psicossocial; IV – especiais de acesso aberto. (Decreto 7.508/2011, arts. 9º e 10) Pegadinha: 'Apenas' a atenção primária; incluir ambulatório especializado como porta de entrada.

144. D — Art. 5º: para ser instituída, a Região de Saúde deve conter, no mínimo, ações e serviços de: I – atenção primária; II – urgência e emergência; III – atenção psicossocial; IV – atenção ambulatorial especializada e hospitalar; V – vigilância em saúde. (Decreto 7.508/2011, arts. 4º e 5º) Pegadinha: Lista incompleta apresentada como suficiente.

145. A — Mortalidade infantil = (óbitos de menores de 1 ano ÷ nascidos vivos) × 1.000 = $12 \div 1.500 \times 1.000 = 8$ por mil nascidos vivos. (Indicadores básicos de saúde (RIPSA)) Pegadinha: Troca de denominador e de faixa etária (< 1 ano × < 5 anos).

146. E — Eficácia: efeito em condições ideais ou alcance dos objetivos; eficiência: relação entre resultados e recursos/custos; efetividade: impacto real nas condições de saúde da população. (Avaliação em saúde (Donabedian; conceitos de eficácia, eficiência e efetividade)) Pegadinha: Troca de conceito vizinho (eficácia × eficiência × efetividade).

147. C — Incidência = casos novos ÷ população em risco × 100.000 = $40 \div 20.000 \times 100.000 = 200$. Prevalência pontual = $70 \div 20.000 \times 100.000 = 350$. (Epidemiologia descritiva – medidas de frequência) Pegadinha: Troca incidência × prevalência e erro de escala.

148. D — Art. 1º, § 1º, da Lei 8.142/1990: a Conferência será convocada pelo Poder Executivo ou, extraordinariamente, por esta ou pelo Conselho de Saúde. (Lei 8.142/1990, art. 1º, § 1º) Pegadinha: 'Exclusivamente' e condicionantes inexistentes.